



DAFTAR USULAN CALON KARYAWAN TETAP
RS PRIMA HUSADA MALANG

1. Profesi Perawat

NO	NAMA LENGKAP	UNIT KERJA	JABATAN	PROFESI	MASA KERJA	HASIL EVALUASI KINERJA	CATATAN IKP
1	Very Susanto, S.Kep.Ns	Direksi	Kepala Bidang Keperawatan	Perawat	6 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
2	Alifia Dian Sukmaningtyas, S.Kep.Ns	Manajemen	Sekretaris Komite PMKP Mutu	Perawat	4 Tahun 1 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
3	Fadhila Ayu Setyani, Amd.Kep	PIPP	Manager On Duty	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
4	Murwani Suryani S, Amd.Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Kepala Ruang	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
5	Amilatul Kholifah, Amd.Kep	IRNA 5C	Kepala Ruang	Perawat	5 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
6	Kiki Sandra, Amd.Kep.	IKO	Pelaksana	Perawat	9 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
7	Adelia May Adetry, Amd.Kep	IRJA	Pelaksana	Perawat	8 Tahun 1 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
8	Tri Ani darma Wanti, A.Md.Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	7 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
9	Safitri Retno Kurniawati, Amd.Kep	CSSD	Pelaksana	Perawat	7 Tahun 8 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
10	Eko Pambudi, Amd.Kep.	IKO	Pelaksana	Perawat	7 Tahun 5 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
11	Nungki Putri Pebriyanti, Amd.Kep	IGD	Pelaksana	Perawat	7 Tahun 5 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
12	Kurnia Setyawan Syah, S.Kep.Ns	IKO	Pelaksana	Perawat	7 Tahun 3 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
13	Agus Hendra Setiawan, S.Kep.Ns	IKO	Pelaksana	Perawat	7 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
14	Agustia Feronika Sari, Amd.Kep	Neonatologi	Pelaksana	Perawat	7 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
15	Laras Wieny Nuriska, Amd. Kep	IRNA 5C	Pelaksana	Perawat	6 Tahun 3 Bulan	Direkomendasikan	KTD (09 November 2024)
16	Nike Kristanti, Amd.Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	6 Tahun 3 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
17	Agus Widodo, Amd.Kep	ICU	Pelaksana	Perawat	6 Tahun 3 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada



18	Resa Novitasari, Amd.Kep	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	6 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
19	Ulfa Agustina, S.Kep.Ns	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	6 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
20	Wibowo Krisdianto, Amd. Kep	IRJA	Pelaksana	Perawat	6 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
21	Ahmad Fadhil Kurniawan, A.Md.Kep	IRNA 5C	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
22	Ani Dwi Karimah, S.Kep.Ns	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
23	Billy Mavino Perkasa, Amd. Kep	IRNA 2C	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
24	Dwinta Widya Navita, A.Md.Kep	ICU	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
25	Fariz Tiarawan Fadil Cahyono, S.Kep.Ns	IGD	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
26	Ivico Regita Moniq, Amd.Kep	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
27	Iqbal, Amd. Kep	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
28	Kholilul Rohman, Amd.Kep	IGD	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
29	Lita Oktavian, Amd.Kep	IGD	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
30	Muhammad Sahri, Amd.Kep	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
31	Oktavia Amelia Sari, Amd.Kep	IRJA	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
32	Rara Ayu Dewanti, S. Kep. Ns	IRJA	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
33	Raysa Rosadila, Amd. Kep	IRJA	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
34	Rendra Tohedy, Amd. Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	KTD (02 Feb 2024)
35	Rizki Ningrum Nadia, Amd. Kep	IRNA 5C	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
36	Sefira Herisky, Amd.Kep	Neonatologi	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
37	Siti Chomariah, Amd.Kep	IRNA 3C Anak	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
38	Syaraswati Silanda, Amd.Kep	IRNA 3C Anak	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada



39	Tatik Widayati, S.Kep.Ns	ICU	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
40	Winda Lestari, S. Kep. Ns	IRJA	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
41	Yulinar Indreswari Ratnaningtias, Amd. Kep	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
42	Yurike Devita Ratna Sari Dewi, S.Kep.Ns	IKO	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
43	Achmad Rudy Harianto S. Kep.Ns	ICU	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
44	Beny Wahyudi, S.Kep.Ns	IGD	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
45	Mokhammad Andi Gusti Wahyu Prianda, Amd. Kep.	IKO	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
46	Octa Fitri Muazizah, S. Tr.Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
47	Rizal Ari Wicaksono , Amd.Kep	IGD	Pelaksana	Perawat	5 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
48	Ayu Regita Cahyani, Amd. Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
49	Fella Pancarani, Amd. Kep	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
50	Saghita Puspita Sari, Amd.Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	KTC (20 Januari 2024)
51	Zahrocha Fathmanda Refarin, Amd. Kep	IGD	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
52	Diah Lusiana Eko Tohari, Amd.Kep	Neonatologi	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
53	Faidatul Chasanah, Amd. Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
54	Ferianto Hendri Cahyono. Amd.Kep	ICU	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
55	Muhammad Ikhwanudin, S.Kep.Ns	IRNA 5C	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
56	Neni Novitasari, Amd. Kep	IRNA 2C	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada



57	Noor Rochmat Hidayatullah, S.Tr.Kep	IGD	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
58	Nurul Cintya Laila Ramadhani, Amd. Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
59	Purwinda Respati Putri, Amd. Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
60	Yusrotul Widat, Amd. Kep	IRNA 3C Anak	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
61	Elok Lonchat Okyani, S.Kep. Ns	IRNA 2C	Pelaksana	Perawat	4 Tahun 1 Bulan	KTD (21 Februari 2023)	Tidak Ada
62	Moch. Mas'ud, A.Md.Kep	IGD	Pelaksana	Perawat	3 Tahun 3 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
63	Rahma Yunita, Amd.Kep	IGD	Pelaksana	Perawat	3 Tahun 3 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
64	Oky Taat Setiawan, S.Kep.Ns	IKO	Pelaksana	Perawat	3 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	KTC (16 Februari 2024)
65	Tika Aryuni Damayanti, S. Kep. Ns	IRJA	Pelaksana	Perawat	3 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
66	Elvin Elsa Maharennny, S.Tr.Kep.Ns	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
67	Firda Ayu Maghfiro, S.Tr.Kep.Ns	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
68	Nura'ini, S. Kep.Ns	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
69	Wahlah, S.Kep.Ns	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
70	Anis Nurlaili, S.Kep.Ns	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
71	Diyah Purwanti, S.Kep. Ns	IRNA 3C Anak	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
72	Rani Karima Rosul, S.Kep.Ns	IGD	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
73	Ns. Nuraini Radika Rifqi, S.Kep	IRNA 3C Anak	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	KTD (10 Januari 2024)
74	Bagus Ardiansyah Putra, S.Kep.Ns	IGD	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
75	Fitri Octavia, Amd. Kep	IRNA 3A & 4A	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
76	Khairun Nisa', Amd. Kep	IRJA	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
77	Lailatul Badriyah, Amd. Kep	IRNA 5C	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	KTD



							(09 Novembe r 2024)
78	Lovely Aulia Edy, Amd,Kep	IGD	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	KTD (16 Februari 2024 ; 20 Februari 2024)
79	Prima Dio Prasojo, S.Tr.Kep	IRNA 3C Anak	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
80	Reyna Oktavia Kristianti, AMD. Kep	IRJA	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
81	Rismaya Felantriardia nti, S.Kep.Ns	Neonatologi	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
82	Rista Alfia Sari, Amd.Kep	Neonatologi	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
83	Septian Teguh Imanda, AMD.Kep	ICU	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
84	Trikaya Inggar Yuniar, AMD. Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
85	Yolanda Sylviana, S.Kep Ns	IRNA 2C	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
86	Eliadi Putra, AMD. Kep	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
87	Anik Wahyu Yulyastanti, S.Kep.Ns	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
88	Arifin Nur Permadi, S.Kep.Ns	IRNA 3C Anak	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
89	Fakhrur Rifqi Aliyanto,S.Ke p.Ns	IGD	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
90	Lusianah Nurul islamiyah,AM d.Kep	ICU	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
91	Sabbih Azma Ridlo, S.Kep.Ns	IRNA 6A, 7A & 8A	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
92	Sintya Rahma Esa Fatmala, S.Kep.Ns	IRNA 2C	Pelaksana	Perawat	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
TOTAL							92



2. Profesi Perawat Gigi

NO	NAMA LENGKAP	UNIT KERJA	JABATAN	PROFESI	MASA KERJA	HASIL EVALUASI KINERJA	CATATAN IKP
1	Ajeng Ika Oktaviana, S.ST	IRJA	Pelaksana	Perawat Gigi	5 Tahun 11 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
TOTAL							1

3. Profesi Bidan

NO	NAMA LENGKAP	UNIT KERJA	JABATAN	PROFESI	MASA KERJA	HASIL EVALUASI KINERJA	CATATAN IKP
1	Tuti Dwi Jayati, A.Md.Keb	IRJA	Pelaksana	Bidan	9 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
2	Aneta Putri Meidikasari, Amd. Keb	Maternitas	Pelaksana	Bidan	7 Tahun 5 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
3	Indri Khatul Inaya, S.St.Keb	IGS	Pelaksana	Bidan	6 Tahun 4 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
4	Elisa Lifatinnura, S.Tr.Keb	Maternitas	Pelaksana	Bidan	5 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
TOTAL							4

4. Profesi Apoteker & Tenaga Teknis Kefarmasian (Farmasi)

NO	NAMA LENGKAP	UNIT KERJA	JABATAN	PROFESI	MASA KERJA	HASIL EVALUASI KINERJA	CATATAN IKP
1	Yuanita Eka Lestari, S.Farm.,Apt	Farmasi	Kepala Instalasi	Apoteker	6 Tahun 7 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
2	Diryati Barin Putri, S. Farm.,Apt	Farmasi	Pelaksana	Apoteker	5 Tahun 6 Bulan	Direkomendasikan	KTD (23 Februari 2024) KTC (23 September 2024)
3	Pipin Purwa Ningrum, S.Farm.,Apt	Farmasi	Pelaksana	Apoteker	4 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
4	Rifdah Bunga Kwintana, S.Farm.,Apt	Farmasi	Pelaksana	Apoteker	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
5	Ajeng Janani,S. Farm., Apt	Farmasi	Pelaksana	Apoteker	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
6	Asharul Fahrizi, S.Farm.,Apt	Farmasi	Pelaksana	Apoteker	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
7	Dia Ayu Wisnu Wardani, A.Md.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	9 Tahun 6 Bulan	Direkomendasikan	KTD (23 Februari 2024)
8	Asih Sulistiorini, AMd.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	9 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
9	Anjani Kusumawati, A.Md.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	8 Tahun 7 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
10	Desy Lailyssholikha, AMd.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	8 Tahun 6 Bulan	Direkomendasikan	KTD (23 Februari 2024)



11	Farda Lolita Meisila, A.Md.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	7 Tahun 8 Bulan	Direkomendasikan	KTC (23 September 2024)
12	Mur'ifatul Amaliya, A.Md.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	7 Tahun 6 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
13	Evan Nur Luthfi Ramadhani, A.Md.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	7 Tahun 5 Bulan	Direkomendasikan	KTC (23 September 2024) KTC (01 maret 2023)
14	Siti Sulistiowati, AMd.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	6 Tahun 6 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
15	Intan Irene Virera, Amd. Si	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	5 Tahun 3 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
16	Laras Hadyaning Tias, S.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	3 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	KTD (23 Februari 2024) KTC (23 September 2024) KNC (25 September 2024)
17	Adelia Rachmawati, AMd.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	2 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Sedang menjalani Sanksi SP1 karena case gudang farmasi
18	Faiqotul Ilma Mufida, A.Md.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	2 Tahun 3 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
19	Fadiyah Isnawati, AMd.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	2 Tahun 2 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
20	Hefti Ari Pransiska, S.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
21	Muva Rendra Irmajati, S.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	2 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
22	Fika Rahma Atika, AMd.Farm	Farmasi	Pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
TOTAL							22



5. Profesi Analis Laboratorium

NO	NAMA LENGKAP	UNIT KERJA	JABATAN	PROFESI	MASA KERJA	HASIL EVALUASI KINERJA	CATATAN IKP
1	Elis Wahyuni, Amd.AK	Laboratorium	Pelaksana	Analisis Laboratorium	7 Tahun 1 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
2	Bagas Dwi Hariyono , Amd. Kes	Laboratorium	Pelaksana	Analisis Laboratorium	5 Tahun 6 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
3	Bella Kristyana Dewi, Amd.AK	Laboratorium	Pelaksana	Analisis Laboratorium	4 Tahun 10 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
4	Arinta Astri Maulina, AMd.Kes	Laboratorium	Pelaksana	Analisis Laboratorium	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
5	Nikmah Widyawati, Amd.Kes	Laboratorium	Pelaksana	Analisis Laboratorium	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
6	Puji Utami, Amd. Kes	Laboratorium	Pelaksana	Analisis Laboratorium	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
7	Saveinisa Satya Abdarahma,S.Tr.Kes	Laboratorium	Pelaksana	Analisis Laboratorium	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
TOTAL							7

6. Profesi Radiografer

NO	NAMA LENGKAP	UNIT KERJA	JABATAN	PROFESI	MASA KERJA	HASIL EVALUASI KINERJA	CATATAN IKP
1	Ayu Bintang Tinara, Amd.Rad	Radiologi	Kepala Ruang	Radiografer	7 Tahun 3 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
2	Isma Mufida, Amd.Rad	Radiologi	Pelaksana	Radiografer	7 Tahun 3 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
3	Erwin Prasetyo Aji, Amd.Rad	Radiologi	Pelaksana	Radiografer	5 Tahun 6 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
4	Fahmi Shohibul Mubarak, Amd.Rad	Radiologi	Pelaksana	Radiografer	4 Tahun 9 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
5	Dinda Ayu Puspita, Amd.Rad	Radiologi	Pelaksana	Radiografer	4 Tahun 1 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
6	Muhammad Iqbal Maulana, Amd.Rad	Radiologi	Pelaksana	Radiografer	4 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	KTD (15 April 2024)
TOTAL							6



7. Profesi Ahli Gizi

NO	NAMA LENGKAP	UNIT KERJA	JABATAN	PROFESI	MASA KERJA	HASIL EVALUASI KINERJA	CATATAN IKP
1	Alfira Chaerunisa, S.Tr.Gz	Gizi	Pelaksana	Ahli Gizi	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
2	Chandrawati Mustikasari, S.Tr.Gz	Gizi	Pelaksana	Ahli Gizi	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
3	Nafisah Ulfa Hasanah, S.Gz	Gizi	Pelaksana	Ahli Gizi	2 Tahun 0 Bulan	Direkomendasikan	Tidak Ada
TOTAL							3

Malang, 14 Desember 2024

Kepala Bidang Umum dan Keuangan



drg. Endy Wira Pradana, M.MRS

PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis



dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi

PLT Kepala Bidang Penunjang Medis



Putri Indah Purnamasari, A.Md.Kep

Kepala Bidang Keperawatan



Ns. Very Susanto, S.Kep

PLT Direktur RS Prima Husada Malang

dr. Nur Mazidah

SDM RS Prima Husada Malang

Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi

LAMPIRAN IKP

IKP 09 November 2024
1) Perawat : Laras Wieny Nuriska, A.Md.Kep
2) Perawat : Lailatul Badriyah, A.Md.Kep

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama : Sdr M
No. RM : 101231
Ruangan : IRNA 5C
Umur * : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan – 1 tahun
☐ > 1 tahun – 5 tahun ☐ > 5 tahun – 15 tahun
☒ > 15 tahun – 30 tahun ☐ > 30 tahun – 65 tahun
☐ > 65 tahun
Jenis kelamin : ☒ Laki-laki ☐ Perempuan
Penanggung biaya pasien : ☐ Pribadi ☐ Asuransi Swasta
☒ BPJS ☐ Lainnya (sebutkan)
Tanggal Masuk Ruangan :

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
09-11-2024 (22.45)	Keluarga pasien tiba- tiba datang ke ruang 5C, perawat M menyakan keluarga :”ada yang bisa di bantu bu?” keluarga menanyakan kamar yang akan di tempati pasien perawat M mengantar keluarga ke ruang bougenvile 2 dan menjelaskan jika ruang kelas 1 berisi 2 bed selanjutnya keluarga pasien turun lagi ke IGD	
09-11-2024 (23.40)	Perawat F via telpon memberitahukan kepada perawat M pasien akan di pindahkan ke ruang 5C karena pasien komplain sudah lama di IGD dan tidak nyaman tetapi belum ada balasan dari DPJP	
09-11-2024 (23.50)	IGD via telpon memberitahukan untuk mengambil pasien ke IGD	
09-11-2024 (23.55)	Perawat M turun ke IGD, perawat F mengoperkan kondisi pasien dan belum adanya advice dari DPJP ke perawat M	
10-11-2024 (00.02)	Perawat M memindahkan pasien ke ruangan 5C dengan kursi roda dan menjelaskan letak bel pasien dan jika butuh bantuan tekan tombol bel	
10-11-2024 (00.45)	Ibu pasien pulang dan pasien sendirian	



10-11-2024 (04.24)	IGD memberitaukan via WA jika pasien rencana operasi pukul 10.00	
10-11-2024 (05.30)	Perawat M memberitahukan ke pasien rencana tindakan operasi pukul 10.00 turun ke kamar operasi jam 09.00 dan kie untuk puasa tidak makan dan minum, serta meminta pasien untuk memberitaukan ke ibunya agar segera ke rumah sakit untuk TTD operasi	
10-11-2024 (06.00)	Perawat M menyiapkan bendelan operasi dan form persetujuan operasi dan anastesi	
10-11-2024 (07.00)	Perawat M mengoperkan kepada shif pagi kalau keluarga belum tanda tangan di form persetujuan operasi karena keluarga masih pulang	
10-11-2024 (07.20)	Perawat L mengecek infus semua pasien dan injeksi pagi . pada saat ke Bougenvile 1 perawat L menanyakan sudah puasa atau belum. pasien menjawab “Sudah puasa”. Pada saat itu pasien masih sendirian tidak ada keluarga pasien.	
10-11-2024 (07.50)	Perawat LB ke laboratorium untuk mengirim bahan TCM dan mengambil tranfusi. Perawat L ke Ny. S (Bougenvile 3) untuk cek GDA, lalu ke Dahlia untuk membenarkan infus pasien yang macet.	
10-11-2024 (08.00)	Perawat L melepas infus pasien rencana KRS perawat LB menginfus pasien dan memasukkan labu darah.	
10-11-2024 (08.10)	Perawat L KIE pasien KRS 2 Perawat LB merapikan syringpump dan monitor yang sudah selesai di pakai.	
10-11-2024 (08.30)	Mengisi kelembapan dan suhu ruangan	
10-11-2024 (08.45)	Perawat LB memasukkan profilaksis dan premed ke Sdr. M kemudian menurunkan pasien ke Kamar IKO tanpa mengecek kelengkapan RM kembali	

Simpulan :

- Jenis Insiden* :
 - ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
 - ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
 - ☒ Kejadian Tidak Cedera / KTC
 - ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
 - ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
- Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
 - ☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
 - ☐ Pasien
 - ☒ Keluarga / Pendamping pasien
 - ☐ Pengunjung



- ☐ Lain-lain(sebutkan)
4. Insiden terjadi pada* :
☐ **Pasien**
☐ Lain-lain(sebutkan)
Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
5. Insiden menyangkut pasien :
☐ **Pasien rawat inap**
☐ Pasien rawat jalan
☐ Pasien UGD
☐ Lain-lain(sebutkan)
6. Tempat Insiden
IRBA 5C
7. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
☐ Anak dan Subspesialisasinya
☐ Bedah dan Subspesialisasinya
☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
☐ THT dan Subspesialisasinya
☐ Mata dan Subspesialisasinya
☐ Saraf dan Subspesialisasinya
☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
☐ Jantung dan Subspesialisasinya
☐ Paru dan Subspesialisasinya
☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
☐ Lain-lain Urologi
8. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
IRNA 5C
9. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
☐ Kematian
☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
☐ Cedera Ringan
☐ **Tidak ada cedera**
10. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
Segera melakukan konfirmasi kepada pasien dan keluarga
11. Tindakan dilakukan oleh* :
☐ Tim, terdiri dari : Perawat, kepala ruangan
☐ Dokter
☐ Perawat
☐ Petugas lainnya
12. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
- ☐ Ya ☐ **Tidak**
Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?
.....
.....
.....
.....

Pembuat Laporan	:	Penerima Laporan	:
-----------------	---	------------------	---



Paraf	:	Paraf	:
Tgl Lapor	:	Tgl terima	:

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

BIRU

☒ **HIJAU**

☐ **KUNING**

MERAH

NB. * = pilih satu jawaban

III. TIPE INSIDEN

NO.	TIPE INSIDEN		SUBTIPE INSIDEN
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. Consent 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i> 2. Diagnosis/ <i>assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart/</i> rekam medik/ <i>assessment/</i> konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands/</i> kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit



			5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ <i>dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. <i>Supply/</i> pesan 7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. <i>Omitted medicine or dose</i> 9. Obat kadaluarsa 10. Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Produk selular 2. Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) 3. Albumin/ plasma protein 4. Immunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Tes pre transfusi 2. Peresepan 3. Persiapan/ <i>dispensing</i> 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. Penyimpanan 7. Monitoring 8. Presentasi/ pemaketan 9. <i>Supply/</i> pesan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah darah/ produk darah 3. Salah dosis/ frekuensi 4. Salah jumlah 5. Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. Obat atau dosis yang diabaikan 9. Darah kadaluarsa 10. Efek samping/ <i>adverse effect</i>



7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	1. Peresepan/ permintaan 2. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 3. <i>Supply</i> / pesan 4. Penyajian 5. <i>Dispensing</i> / alokasi 6. Pengantaran 7. Pemberian 8. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran 5. <i>Supply</i> / order
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas 3. Salah <i>rate/ flow</i> / konsentrasi 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan 7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidakersediaan 3. <i>Inappropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederaikan diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Velbed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga



			8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangan tajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. <i>Protocols/ Kebijakan/ SOP Guideline</i> c. Ketersediaan/ <i>Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ <i>pick up transport sorting data entry</i> proses verifikasi/ validasi hasil	

1. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)
Miss komunikasi antara pasien, keluarga dan perawat. perawat sudah meminta persetujuan kepada pasien untuk tindakan operasi, tetapi perawat lali untuk meminta tanda tangan dan itu dipermasalahkan oleh keluarga.



2. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)
Miss komunikasi antara pasien, keluarga dan perawat.
perawat sudah meminta persetujuan kepada pasien untuk tindakan operasi, tetapi perawat lali untuk meminta tanda tangan dan itu dipermasalahkan oleh keluarga.
3. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	Miss komunikasi antara pasien, keluarga dan perawat. perawat sudah meminta persetujuan kepada pasien untuk tindakan operasi, tetapi perawat lali untuk meminta tanda tangan dan itu dipermasalahkan oleh keluarga.	Selalu croscek kelengkapan dan tanda tangan pasien karena itu yang menjadi pelindung kita sebagai tenaga Kesehatan
2		

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain
Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

IKP 02 Februari 2024

Perawat : Rendra Tohedy, A.Md.Kep

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama : Ny. Siti Rosi'ah

No. RM : 204201

Ruangan : IRNA 7A

Umur * :

☐ 0-1 bulan

☐ > 1 bulan – 1 tahun

☐ > 1 tahun – 5 tahun

☐ > 5 tahun – 15 tahun

☐ > 15 tahun – 30 tahun

☐ > 30 tahun – 65 tahun

☒ > 65 tahun

Jenis kelamin :

☐ Laki-laki

☒ Perempuan

Penanggung biaya pasien :

☐ Pribadi

☒ BPJS

☐ Asuransi Swasta

☐ Lainnya (sebutkan)

Tanggal Masuk Ruangan :

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
2-2-2024 Jam 22.00	Pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri pinggang setelah jatuh dikamar mandi diterima oleh dokter sofia dan dikonsulkan pada DPJP dokter Oka, Sp.OT mendapatkan advice untuk MRS. Dokter sofia melaporkan kepada dokter Oka melalui Wa : Selamat malam dokter, dari IGD RS Prima Husada, izin konsul pasien baru masih kami rawat jalankan dokter: Ny. Siti Rosi'ah / 71th / Bpjs S/ pasien datang dengan keluhan terjatuh duduk di kamar mandi sore ini, pusing (+) mual (-) muntah (-) vas 8-9, demam (-) batuk (+) seminggu, makan dan minum dbn, bab dan bak dbn RPD : OA, Rhinitis Allergic, Spondylolysis, HT RPO : obat racikan dari dr. Dewi, Sp.S -> (paracetamol, valisanbe) 1x1 , lafalos cream 3x1 ue,	 Selamat malam dokter, dari IGD RS Prima Husada, izin konsul pasien baru masih kami rawat jalankan dokter: Ny. Siti Rosi'ah / 71th / Bpjs S/ pasien datang dengan keluhan terjatuh duduk di kamar mandi sore ini, pusing (+) mual (-) muntah (-) vas 8-9, demam (-) batuk (+) seminggu, makan dan minum dbn, bab dan bak dbn RPD : OA, Rhinitis Allergic, Spondylolysis, HT RPO : obat racikan dari dr. Dewi, Sp.S -> (paracetamol, valisanbe) 1x1, lafalos cream 3x1 ue, valisartan 0-0-1, amlodipin 1-0-0, methylprednisolon 1-0-0 O/ KU CM GCS 456 TD 140/80mmhg HR 100bpm RR 24 x/m S 36.7 SpO2 99%room air Generalisata : 1. Head : A/I/C/D -/-/-/- 2. Neck : simetris +/-, pembesaran KGB - 3. Thorax : -cor : S1S2 tunggal murmur- gallop- -Pulmo : vas +/-, RH +/-, WH +/-, retraksi - 4. Abdomen : BU +, nyeri tekan (+) 5. Ekstremitas : Akral dingin (-), edema -/-/-/- 6. Vas 8-9, ROM Terbatas A/ Spondilolistesis L5 Mohon advice terapi selanjutnya Dokter, terima kasih



	valsartan 0-0-1, amlodipin 1-0-0, methyprednisolon 1-0-0 O/ KU CM GCS 456 TD 140/80mmhg HR 100bpm RR 24 x/m S 36.7 SpO2 99%room air Generalisata : 1. Head : A/I/C/D -/-/- 2. Neck : simetris +/+, pembesaran KGB - 3. Thorax : •cor : S1S2 tunggal, murmur-, gallop- •Pulmo : ves +/+, RH -/-, WH -/-, retraksi - 4. Abdomen : BU +, nyeri tekan (+) 5. Ekstremitas : Akral dingin (-), edema -/-/- 6. Vas 8-9, ROM Terbatas A/ Spondilolistesis L5 Mohon advice terapi selanjutnya Dokter, terima kasih 🙏 Pasien hanya mengeluhkan nyeri di punggung post jatuh dari kamar mandi, dengan vas 8-9 selama di igd tidak ada mengeluhkan luka di lutut dan membaik dengan injeksi obat, pasien ada riwayat OA dan Spondylolysis	
--	--	--



3-2-2024
Jam 01.30

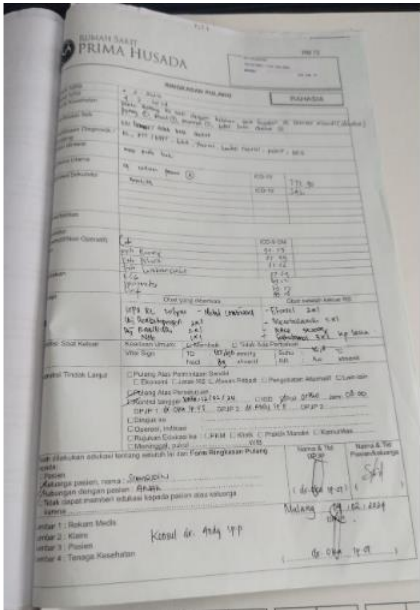
Pasien diterima di IRNA 7A
Hasil pengkajian keperawatan
rawat inap pada pemeriksaan
muskulo skeletal dan kulit tertulis
normal.

Telusur jadwal : perawat
betugas malam yaitu
Rendra Tohedy, Amd. Kep dan
Ns. Nazhilatul Rizkia, S. Tr. Kep

Menurut dokter Oka, pasien
tidak mengatakan bahwa
terdapat luka dan tidak
mengeluh nyeri atas luka
tersebut. Saat dokter Oka visite
dan melakukan pemeriksaan,
pasien selalu menggunakan
celana.

Perawat Tohedy yang menerima
pasien juga mengatakan, pasien
tidak mengatakan adanya luka,
pasien hanya mengeluh nyeri
pinggang dan terkadang sesak.



4-2-2024	Pasien KRS	
17-2-2024	Pasien kontrol ke poli dokter Oka dan mengatakan ada luka di kakinya. Dokter Oka complain pada perawat bahwa tidak menerima laporan dari IGD. Perawat menyampaikan pada PIPP. PIPP segera menghubungi dokter Sofia untuk kronologi lebih jelas. Pasien terlambat kontrol, yang seharusnya dijadwalkan kontrol tanggal 12 tetapi baru kontrol di tanggal 17 Dokter Oka menanyakan kepada pasien, mengapa pasien tidak mengatakan pada dokter jika ada luka selama dirawat dan pasien mengatakan lupa.	

Simpulan :

1. DPJP complain terkait kondisi pasien yang tidak dilaporkan dengan lengkap oleh dokter IGD
2. Selama pasien di rawat , pasien tidak mengeluh adanya luka bahkan ketika Dpjp visite dan perawat melakukan tindakan
2. Jenis Insiden* :
 - ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
 - ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
 - ☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC
 - ☒ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
 - ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
3. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
 - ☒ Karyawan : Dokter
 - ☐ Pasien
 - ☐ Keluarga / Pendamping pasien
 - ☐ Pengunjung



- ☐ Lain-lain(sebutkan)
4. Insiden terjadi pada* :
✓ Pasien
☐ Lain-lain(sebutkan)
Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
5. Insiden menyangkut pasien :
✓ Pasien rawat inap
☐ Pasien rawat jalan
☐ Pasien UGD
☐ Lain-lain(sebutkan)
6. Tempat Insiden
IGD dan IRNA 7A
7. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
☐ Anak dan Subspesialisasinya
☐ Bedah dan Subspesialisasinya
☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
☐ THT dan Subspesialisasinya
☐ Mata dan Subspesialisasinya
☐ Saraf dan Subspesialisasinya
☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
☐ Jantung dan Subspesialisasinya
☐ Paru dan Subspesialisasinya
☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
✓ Orthopedi dan subspesialisnya
8. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
IGD dan IRNA
9. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
☐ Kematian
☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
✓ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
☐ Cedera Ringan
☐ Tidak ada cedera
10. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
Melakukan telusur dan didapatkan hasil :
3. DPJP complain terkait kondisi pasien yang tidak dilaporkan dengan lengkap oleh dokter IGD
4. selama dirawat dan dokter Oka Visite, pasien tidak pernah mengeluhka adanya luka dan pasien menggunakan celana panjang. Begitupun dengan perawat yang bertugas, pasien tidak mengeluh adanya luka ketika perawat melakukan tindakan.
11. Tindakan dilakukan oleh* :
✓ Tim, terdiri dari : sub komite keselamatan pasien, sekretaris komite PMKP, kepala IRNA 7A, perawat IRNA 7A, sekretaris komite medis
☐ Dokter
☐ Dokter
☐ Perawat
☐ Petugas lainnya
12. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
- ☐ Ya ✓ Tidak
Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?



Pembuat Laporan	: Alifia	Penerima Laporan	: Alifia
Paraf	:	Paraf	:
Tgl Lapor	:	Tgl terima	:

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

BIRU ☐ **HIJAU**

☐ **KUNING**

☒ **MERAH**

NB. * = pilih satu jawaban

III. TIPE INSIDEN

No.	Tipe Insiden	Subtype Insiden	
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. <i>Consent</i> 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining 2. <i>Diagnosis/ assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart/</i> rekam medik/ <i>assessment/</i> konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands/</i> kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen



			- Salah dokumen/ salah orang - Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	- Bakteri - Virus - Jamur - Parasit - Protozoa - Rickettsia - Prion/ partikel protein yang infeksius - Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	<i>Bloodstream</i> - Bagian yang dioperasi - Abses - Pneumonia - Kanul IV - Protesis infeksi - Drain/ tube urin - Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	- Daftar Medikasi - Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	- Peresepan - Persiapan/ <i>dispensing</i> - Pemaketan - Pengantaran - Pemberian <i>Supply/</i> pesan - Penyimpanan - Monitoring
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah obat
			- Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi - Salah formulasi/ presentasi - Salah rute pemberian - Salah jumlah/ kuantitas - Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi - Kontraindikasi - Salah penyimpanan <i>Omitted medicine or dose</i> - Obat kadaluarsa - Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	- Produk selular - Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) - Albumin/ plasma protein - Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	- Tes pre transfusi - Peresepan - Persiapan/ <i>dispensing</i> - Pengantaran - Pemberian - Penyimpanan - Monitoring - Presentasi/ pemaketan <i>Supply/</i> pesan
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah darah/ produk darah - Salah dosis/ frekuensi - Salah jumlah - Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi - Kontraindikasi - Salah penyimpanan - Obat atau dosis yang diabaikan



			9. Darah kadaluarsa 10. Efek samping/ <i>adverse effect</i>
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	1. Peresepan/ permintaan 2. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 3. <i>Supply</i> / pesan 4. Penyajian 5. <i>Dispensing</i> / alokasi 6. Pengantaran 7. Pemberian 8. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran 5. <i>Supply</i> / order
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas 3. Salah <i>rate/ flow</i> / konsentrasi 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan 7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. <i>Inapropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembronon/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Vel/bed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet



			6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangantajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. <i>Protocols/</i> Kebijakan/ SOP Guideline c. Ketersediaan/ <i>Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ <i>pick up transport sorting data entry</i> proses verifikasi/ validasi hasil	

1. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)

5. DPJP complain terkait kondisi pasien yang tidak dilaporkan dengan lengkap oleh dokter IGD
6. Selama dirawat dan dokter Oka Visite, pasien tidak pernah mengeluhka adanya luka dan pasien menggunakan celana panjang. Begitupun dengan perawat yang bertugas, pasien tidak mengeluh adanya luka ketika perawat melakukan tindakan.



7. Perawat tidak menuliskan nama dibawah tanda tangan pada pendokumentasian rekam medis
2. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)
 8. DPJP complain terkait kondisi pasien yang tidak dilaporkan dengan lengkap oleh dokter IGD
 9. Selama dirawat dan dokter Oka Visite, pasien tidak pernah mengeluhka adanya luka dan pasien menggunakan celana panjang. Begitupun dengan perawat yang bertugas, pasien tidak mengeluh adanya luka ketika perawat melakukan tindakan.
 10. Perawat tidak menuliskan nama dibawah tanda tangan pada pendokumentasian rekam medis
3. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	DPJP complain terkait kondisi pasien yang tidak dilaporkan dengan lengkap oleh dokter IGD	Pelaporan kondisi pasien dari IGD harus dikonsulkan pada DPJP dengan lengkap dan jelas
2	Selama dirawat dan dokter Oka Visite, pasien tidak pernah mengeluhka adanya luka dan pasien menggunakan celana panjang. Begitupun dengan perawat yang bertugas, pasien tidak mengeluh adanya luka ketika perawat melakukan tindakan.	Baik perawat maupun DPJP harus mengkaji ulang Ketika menerima pasien baru dari IGD Baik perawat dan DPJP harus melakukan pemeriksaan head to toe ketika menerima pasien baru.
3	Perawat tidak menuliskan nama dibawah tanda tangan pada pendokumentasian rekam medis	Supervisi berjentang dari kepala ruangan dan kbid keperawatan harus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perawat dalam kelengkapan dokumentasi rawat inap

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain
Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselaman Pasien



IKP 20 Januari 2024

- 1) Perawat : Saghita Puspita Sari, A.Md.Kep
- 2) Perawat : Lovely Aulia Edy, A.Md.Kep

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

IV. DATA PASIEN

Nama : Achmad Rotib
No. RM : 111431
Ruangan : D7A-11
Umur * : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan – 1 tahun
☐ > 1 tahun – 5 tahun ☐ > 5 tahun – 15 tahun
☐ > 15 tahun – 30 tahun ☒ > 30 tahun – 65 tahun
☐ > 65 tahun
Jenis kelamin : ☒ Laki-laki ☐ Perempuan
Penanggung biaya pasien : ☐ Pribadi ☐ Asuransi Swasta
☐ BPJS ☐ Lainnya (sebutkan)
Tanggal Masuk Ruangan : 19/01/2024

V. RINCIAN KEJADIAN

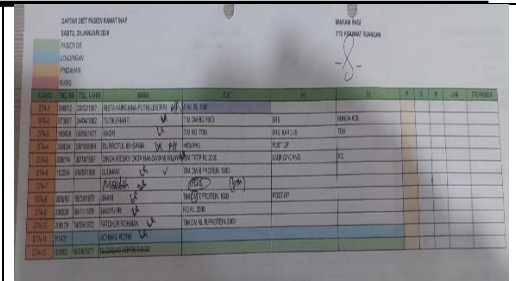
1. Tanggal dan Waktu Insiden

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
20/01/2024 14.00	Pasien dengan diagnosa post op debridement + necrotomy gangren necrotic diabetic, DPJP dr.Anton, Sp.B. Hasil laboratorium Hb: 8,7 g/dL, Ureum: 108,3 mg/dL, BUN: 50,6 mg/dL, Creatinin: 5,10 mg/dL, GDS (MRS): 177 mg/dL. Saat makan pagi, penyaji (tyas) meng_update daftar nama pasien di Lt.7 dengan perawat shift malam (Saghita dan Asta). Penyaji menanyakan apakah ada pasien yang puasa. Perawat menjawab tidak ada, hanya diet MSS a/n Ny. Maidah. Tyas dibantu oleh Duwi Ratna saat distribusi makanan. Pasien Tn. Achmad Rotib puasa rencana operasi jam 06.00 (jam 04.45 sudah turun ke ruang IKO). Akan tetapi, diberikan makan pagi dan minuman teh di meja Tn. Achmad Rotib oleh penyaji (Duwi Ratna) meskipun telah mengetahui pasien tidak ada di ruangnya (sudah di IKO). Setelah operasi, Tn. Achmad Rotib naik ke ruangan Lt.7 jam 10.00. Di meja	 



pasien masih terdapat makan pagi dan minuman teh. Saat makan siang, penyaji (Sabrina) memberikan makan siang dan mengetahui masih ada box makan pagi beserta minumannya belum diambil oleh CS pantry. Saat ahli gizi middle (Chandra) mengkaji diet pasien jam 14.00, Chandra menemukan pasien telah meminum teh tersebut pasca operasi, namun kedua box makan sudah tidak ada di meja pasien.

Penyaji: Tyas, Duwi Ratna
Perawat 7A: Saghita, Asta
Ahli gizi: Chandra
CS pantry: Doni



Kesimpulan : Kesalahan Pemberian Diet

13. Jenis Insiden* :
 - ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
 - ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
 - ☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC
 - ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
 - ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
14. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
 - ☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
 - ☐ Pasien
 - ☐ Keluarga / Pendamping pasien
 - ☐ Pengunjung
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
15. Insiden terjadi pada* :
 - ☐ Pasien
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)

Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
16. Insiden menyangkut pasien :
 - ☐ Pasien rawat inap
 - ☐ Pasien rawat jalan
 - ☐ Pasien UGD
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
17. Tempat Insiden
Gedung A Lt.7 Ruang Dahlia Bed 11
(Tempat pasien berada)
18. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
 - ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anak dan Subspesialisasinya
 - ☐ Bedah dan Subspesialisasinya
 - ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
 - ☐ THT dan Subspesialisasinya
 - ☐ Mata dan Subspesialisasinya
 - ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anestesi dan Subspesialisasinya
 - ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya



- ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
 - ☐ Paru dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
 - ☐ Lain-lain Urologi
19. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden Instalasi Gizi dan IRNA 7A
20. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
- ☐ Kematian
 - ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
 - ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
 - ☐ Cedera Ringan
 - ☒ Tidak ada cedera
21. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
- ✓ Mengingatkan penyaji untuk melakukan komunikasi efektif dan melakukan operan diet dengan tepat.
 - ✓ Mengingatkan CS pantry untuk mengambil peralatan makan yang telah digunakan sesuai jadwal pengambilan.
22. Tindakan dilakukan oleh* :
- ☐ Tim, terdiri dari :
 - ☐ Dokter
 - ☐ Perawat
 - ☒ Petugas lainnya (Instalasi Gizi)
23. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
- ☒ Ya
 - ☐ Tidak
- Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
- Kapan? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?**
- Pada 13 November 2023
- ✓ Melakukan pelatihan identifikasi pasien.
 - ✓ Mengingatkan penyaji untuk lebih teliti dalam membaca label dan pemesanan diet pasien.

Pembuat Laporan	: Suci Nur Pratiwi, S.Gz	Penerima Laporan	: Ns. Alifia Dian S, S.Kep
Paraf		Paraf	:
Tanggal Lapor	: 20/01/2024	Tanggal Terima	: 20/01/2024

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

☒ **BIRU** ☐ **HIJAU** ☐ **KUNING** ☐ **MERAH**

NB. * = pilih satu jawaban

VI. **TIPE INSIDEN**

NO.	TIPE INSIDEN	SUBTIPE INSIDEN
1.	Administrasi Klinik	a. Proses 1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. <i>Consent</i>



			10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i> 2. Diagnosis/ <i>assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart/</i> rekam medik/ <i>assessment/</i> konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ Guideline 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands/</i> kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ illegible
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit 5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ <i>dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. <i>Supply/</i> pesan



			7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. <i>Omitted medicine or dose</i> 9. Obat kadaluarsa 10. Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Produk selular 2. Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) 3. Albumin/ plasma protein 4. Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Tes pre transfusi 2. Peresepan 3. Persiapan/ <i>dispensing</i> 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. Penyimpanan 7. Monitoring 8. Presentasi/ pemaketan 9. <i>Supply/</i> pesan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah darah/ produk darah 3. Salah dosis/ frekuensi 4. Salah jumlah 5. Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. Obat atau dosis yang diabaikan 9. Darah kadaluarsa 10. Efek samping/ <i>adverse effect</i>
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	1. Peresepan/ permintaan 2. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 3. <i>Supply/</i> pesan 4. Penyajian 5. <i>Dispensing/</i> alokasi 6. Pengantaran 7. Pemberian 8. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran 5. <i>Supply/</i> order
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas



			3. Salah <i>rate/ flow/</i> konsentrasi 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan 7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. <i>Inapropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminatif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Velbed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangan tajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah



		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. <i>Protocols/</i> Kebijakan/ SOP Guideline c. Ketersediaan/ <i>Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ <i>pick up transport sorting data entry</i> proses verifikasi/ validasi hasil	

4. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)
Kesalahan pemberian diet karena tidak memberikan informasi diet dengan tepat
5. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)
- ✓ Perawat tidak memberikan informasi dengan benar
 - ✓ Penyaji tidak melakukan identifikasi dan komunikasi dengan benar
 - ✓ CS pantry tidak mengambil alat makan pasien sesuai jam pengambilan

6. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	Perawat tidak memberikan informasi dengan tepat	• Meningkatkan komunikasi efektif. • Melakukan kolaborasi yang baik diantara rekan kerja. • Memberikan informasi yang tepat terkait pasien.
2	Penyaji tidak melakukan identifikasi dan komunikasi dengan benar	• Melakukan pelatihan identifikasi pasien dan komunikasi efektif. • Memintakan tanda-tangan pasien sebagai bukti serah terima diet pasien. • <i>Crosscheck</i> diet oleh perawat ruangan saat diminta tanda-tangan oleh penyaji pada form pemesanan diet pasien. • Menjalankan SPO distribusi makanan pasien.
3	CS pantry tidak mengambil alat makan pasien sesuai jam pengambilan	• Melakukan pelatihan identifikasi pasien dan komunikasi efektif. • Memintakan tanda-tangan pasien sebagai bukti serah terima diet pasien.



		• <i>Crosscheck</i> diet oleh perawat ruangan saat diminta tanda-tangan oleh penyaji pada form pemesanan diet pasien. • Menjalankan SPO distribusi makanan pasien. •
--	--	--

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain
Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselaman Pasien



IKP 16 Februari 2024

Perawat : Ns. Oky Taat Setiawan, S.Kep

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

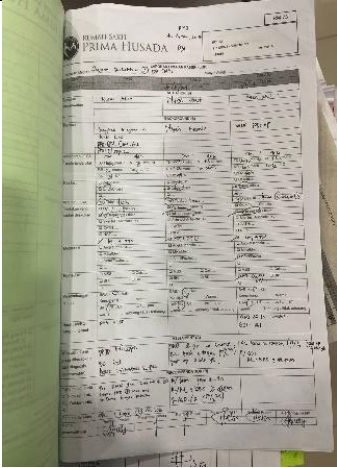
LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama : Tn. Rohim
No. RM : 173278
Ruangan : 6A
Umur * : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan – 1 tahun
☐ > 1 tahun – 5 tahun ☐ > 5 tahun – 15 tahun
☐ > 15 tahun – 30 tahun ☒ > 30 tahun – 65 tahun
☐ > 65 tahun
Jenis kelamin : ☒ Laki-laki ☐ Perempuan
Penanggung biaya pasien : ☐ Pribadi ☐ Asuransi Swasta
☒ BPJS ☐ Lainnya (sebutkan)
Tanggal Masuk Ruangan : 16/02/2024

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
16/02/2024	tgl 16 /2/2024 skitar jam 10.00 Perawat Rosi operan px dari IGD. Isi operannya : rencana Pro DNN jam 13.00, lapor IKO + , dr.Dino tunggu balasan. balasan dr.Dino di teruskan ke ruangan, advice nya : metoclo + PRC. Di orderkan labu darah oleh perawat Velly. Karena sudah mendekati jam turun ke Iko, akhirnya jam 12.00 perawat Rosi mengantar Tn.Rohim ke IKO sekaligus mengambil premed dan BHP tanpa PRC karena Darah belum datang.	
Jam 14.00	Perawat Oki tidak tlp ke ruangan untuk menyampaikan informasi perubahan jadwal operasi yang awalnya jam 13.00 menjadi 16.30. Akirnya perawat Rosi kembali ke ruangan, dengan membawa BHP	

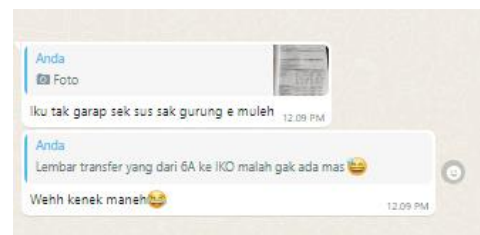
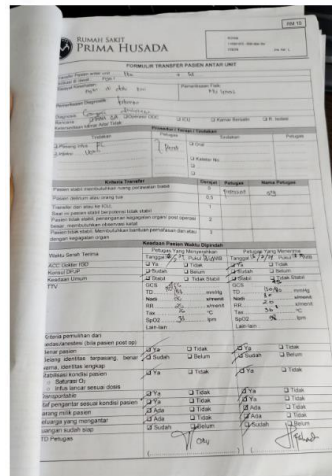


Jam 14.30	op dan premed obat pasien.	
	Saat operan, perawat Vely tidak mengoperkan secara lisan kepada perawat Zia bahwa ada advice PRC 1 labu dari dr. Dino, hanya menyampaikan premed dan profilaksis yang sudah diambil dan disiapkan diruangan oleh perawat vely.	
Jam 15.00	Saat pulang shift sekitar pukul 14.30, perawat vely membawa RM Tn. Rohim untuk operan ke IKO. Perawat vely melakukan serah terima RM dengan perawat Oky dan tidak menyampaikan bahwa ada advice PRC 1 labu dari dr. Dino, hanya menyampaikan premed dan profilaksisnya saja.	
	Perawat Fahad menurunkan pasien Tn. Rohim ke IKO, dan memberikan premed dan profilaksis kepada pasien di ruang Premed. Lalu mengkonfirmasi kepada perawat IKO bahwa perawat vely sudah melakukan operan dengan perawat IKO. Kemudian perawat Fahad Kembali ke ruangan It 6A.	
	Saat mengambil pasien dari IKO, perawat IKO juga tidak menyampaikan bahwa ada labu darah yang belum diambil di laboratorium. Dari pihak laboratorium juga tidak konfirmasi ke ruangan It 6A bahwa jika labu darah Tn. Rohim sudah dating.	



Hasil telusur rekam medis ditemukan

1. Lembar transfer dari IRNA 6A ke IKO tidak ditemukan
2. Lembar transfer dari IKO ke lantai 6A ditanda tangani oleh perawat RR (oky) padahal perawat oky sudah lepas dinas artinya perawat oky sudah mengisi sebelum pulang.



Simpulan : tidak dilakukannya advice pemberian transfusi karena operan shift yang tidak jelas, ketidaktelitian perawat dalam menginput Tindakan pada SIMRS, tidak dilakukannya pendokumentasian laporan labu darah datang.

3. Jenis Insiden* :
 - ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
 - ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
 - ☒ Kejadian Tidak Cedera / KTC
 - ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
 - ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
4. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
 - ☒ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
 - ☐ Pasien
 - ☐ Keluarga / Pendamping pasien
 - ☐ Pengunjung
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
5. Insiden terjadi pada* :
 - ☒ Pasien
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
 - Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
6. Insiden menyangkut pasien :
 - ☒ Pasien rawat inap
 - ☐ Pasien rawat jalan
 - ☐ Pasien UGD
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
7. Tempat Insiden
Irna 6A
8. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
 - ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anak dan Subspesialisasinya
 - ☒ Bedah dan Subspesialisasinya
 - ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
 - ☐ THT dan Subspesialisasinya



- ☐ Mata dan Subspesialisasinya
- ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
- ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
- ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
- ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
- ☐ Paru dan Subspesialisasinya
- ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
- ☐ Lain-lain Urologi

9. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
Irna 6A

10. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :

- ☐ Kematian
- ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
- ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
- ☐ Cedera Ringan
- ✓ Tidak ada cedera

11. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :

Melakukan telusur pada unit unit terkait dengan hasil temuan :

1. Operan antar shift tidak dilakukan dengan baik
2. Serah terima labu darah dating tidak didokumentasikan
3. Labu darah belum di input pada billing SIMRS sehingga tidak terlacak

12. Tindakan dilakukan oleh* :

✓ Tim, terdiri dari : sub komite keselamatan pasien, sekretaris komite PMKP, kepala
IRNA 6A, perawat IRNA 6A, perawat RR IKO, petugas laboratorium

- ☐ Dokter
- ☐ Perawat
- ☐ Petugas lainnya

13. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*

- ☐ Ya
- ✓ Tidak

Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.

Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

.....
.....
.....
.....

Pembuat Laporan	:Vely, Zia, Rosi, Fahad	Penerima Laporan	Sekretaris komite PMKP
Paraf	:	Paraf	:
Tgl Lapor	: 23/02/2024	Tgl terima	: 25 Februari 2024

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

✓ **BIRU** **HIJAU** **KUNING** **MERAH**

NB. * = pilih satu jawaban

III. TIPE INSIDEN

NO.	TIPE INSIDEN		SUBTIPE INSIDEN
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien



			9. <i>Consent</i> 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i> 2. Diagnosis/ <i>assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart/</i> rekam medik/ <i>assessment/</i> konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands/</i> kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	3. Bakteri 4. Virus 5. Jamur 6. Parasit 7. Protozoa 8. Rickettsia 9. Prion/ partikel protein yang infeksius 10. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ <i>dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian



			6. <i>Supply/</i> pesan 7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. <i>Ommited medicine or dose</i> 9. Obat kadaluarsa 10. Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Produk selular 2. Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) 3. Albumin/ plasma protein 4. Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Tes pre transfusi 2. Peresepan 3. Persiapan/ <i>dispensing</i> 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. Penyimpanan 7. Monitoring 8. Presentasi/ pemaketan 9. <i>Supply/</i> pesan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah darah/ produk darah 3. Salah dosis/ frekuensi 4. Salah jumlah 5. Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. Obat atau dosis yang diabaikan 9. Darah kadaluarsa 10. Efek samping/ <i>adverse effect</i> 11. Transfusi tidak diberikan
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	1. Peresepan/ permintaan 2. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 3. <i>Supply/</i> pesan 4. Penyajian 5. <i>Dispensing/</i> alokasi 6. Pengantaran 7. Pemberian 8. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran



			5. Supply/ order
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas 3. Salah <i>rate/ flow/</i> konsentrasi 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan 7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. <i>Inapropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	4. Tersandung 5. Slip 6. Kolaps 7. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Velbed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangantajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain	12. Paparan listrik/radiasi 13. Paparan suara/ getaran



		menyebabkan cedera	14. Paparan tekanan udara 15. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. <i>Protocols/ Kebijakan/ SOP Guideline</i> c. Ketersediaan/ <i>Adequacy</i>	- Belum ada SPO penginputan Tindakan - SPO pengambilan labu darah belum dijalankan dengan maksimal - operan antar shift tidak dijalankan dengan baik.
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ <i>pick up transport sorting data entry</i> proses verifikasi/ validasi hasil	

3. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)

Transfusi darah tidak dilakukan kepada pasien karena

1. Operan antar shift tidak dilakukan dengan baik
2. Serah terima labu darah dating tidak didokumentasikan
3. Labu darah belum di input pada billing SIMRS sehingga tidak terlacak

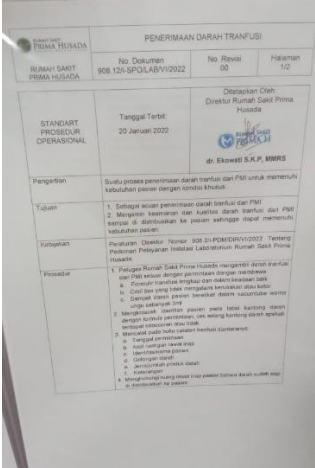
4. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)

1. Operan antar shift tidak dilakukan dengan baik
2. Serah terima labu darah dating tidak didokumentasikan
3. Labu darah belum di input pada billing SIMRS sehingga tidak terlacak

5. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	Operan antar shift tidak dilakukan dengan baik	4. Supervisi kepala ruangan untuk evaluasi bahwa operan sudah dilakukan dengan baik. 5. Tulis dengan jelas Tindakan yang sudah dilakukan dan rencana yang harus dikerjakan oleh shift selanjutnya 6. Menyusun SPO serah terima pasien antar shift dan SPO input Tindakan transfuse pada SIMRS (konsul dengan mas ery)
2	Serah terima labu darah tidak di dokumentasikan	Meningkatkan kepatuhan dokumentasi pemberian informasi



		bahwa labu darah telah datang & dokumentasi serah terima labu darah (SPO sudah ada) Konfirmasi bisa dilakukan via WA jika ruangan tidak mengangkat tlp 
3	Labu darah belum di input pada billing SIMRS sehingga tidak terlacak	Menyusun SPO serah terima pasien antar shift dan SPO input Tindakan transfuse pada SIMRS (konsul dengan mas ery)
4	Tidak disampaikannya jadwal perubahan Operasi (SBAR tidak berjalan dengan maksimal)	Evaluasi oleh kepala unit IKO untuk meningkatkan SBAR dan komunikasi efektif

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain
Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien



IKP 20 Februari 2024
Perawat : Lovely Aulia Edy, A.Md.Kep

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama : Ny. J (64 th)
No. RM : 209598
Ruangan : Lantai 6A
Umur * : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan – 1 tahun
☐ > 1 tahun – 5 tahun ☐ > 5 tahun – 15 tahun
☐ > 15 tahun – 30 tahun ☒ > 30 tahun – 65 tahun
☐ > 65 tahun
Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☒ Perempuan
Penanggung biaya pasien : ☐ Pribadi ☐ Asuransi Swasta
☒ BPJS ☐ Lainnya (sebutkan)
Tanggal Masuk Ruangan : 18 – 02 - 2024

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden : 20-02-2024

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
20.01	Dokter yoga, Sp. JP menyampaikan keluhan atas terjadinya insiden keselamatan pasien kepada direktur. Masalah segera ditelusuri.	20.00 RSPHM dr.Yoga Sp.J... 18.46 Hari ini Dok. Saya komplain dengan perawat lantai 7 19.53 Pasien saya HF sesak... Drip furosemide... Masih saya instruksi untuk masuk furosemide 20mg/ jam 19.54 Tadi siang akses vena lepas 19.54 8 jam pasien gak masuk obat IV 19.54 Ini saya mint echo juga diantar pakai kursi roda... Bukan bed... Padahal pasien sesak... Lebih fatal lagi tanpa oksigen dan tidak ada perawat ruangan menemani 19.55 Saya mau ada diskusi dengan kepala ruangan dan perawat yang bertugas 19.56 Ini KESALAHAN 19.56 Baik dokter 19.59 Mohon maaf untuk kelalaian
KRONOLOGI		
13.30	Infus pasien terlepas karena tertarik oleh pasien. Perawat shift pagi mencoba memasang infus kembali tetapi tidak bisa dan tidak meminta tolong pada teman teman di lantai 7 dan 8.	



		Perawat pagi yang bertugas adalah Elsa dan Fahad.	
14.00		Operan jaga dengan shift sore dan infus Ny. J belum terpasang dioperkan pada shift sore yaitu perawat Vely. Sesuai jadwal, perawat Vely seharusnya berjaga sendiri dan oleh kepala ruang diperbantukan perawat Nata untuk berugas dilantai 6A bersama perawat Vely.	
15.15		Perawat Vely mengasisteni dokter Farid	
15.30		Obat dari farmasi datang. Perawat Vely dan Perawat Nata menyiapkan obat	
16.00		Pasien loadingan datang	
16.25		Perawat Vely menginfus dan mengerjakan pasien baru dan Perawat Nata melakukan TTV. Perawat tidak menyadari bahwa infus Ny. J belum terpasang	
17.00		Perawat Vely dan Perawat Nata melakukan injeksi pasien. Dan perawat menerima menerima tlf dari radiologi bahwa Ny. J bisa diturunkan untuk USG.	
17.30		Perawat Nata menurunkan Ny. J untuk dilakukan USG. Pasien diantar dengan kursi roda. Pasien gagal USG karena pasien tidak bisa terlentang dengan maksimal karena pasien merasa sesak. Akhirnya pasien kembali ke ruangan.	
18.00		Perawat Vely menurunkan 2 pasien ke IKO rencana operasi dengan DPJP dokter Zaky Sp.B	
19.15		Perawat Dhani (Perawat Poli) menelfon dan menyampaikan bahwa Ny. J diijinkan untuk turun ke poli jantung guna melaksanakan pemeriksaan Echo. Bersamaan dengan itu pasien dari IGD yaitu Ny. S dinaikkan ke lantai 6A. Karena ditakutkan perawat Nata belum bisa menerima informasi operan dengan maksimal, maka diputuskan perawat Nata mengantarkan Ny. J untuk Echo dan perawat Vely operan dengan perawat IGD. Perawat Nata mengantarkan Ny. J untuk pemeriksaan Echo dengan kursi roda serta tanpa oksigen. Perawat Nata tidak menyadari bahwa pasien tidak terpasang infus.	
20.00		Perawat Velly telah menyelesaikan pasien baru dari IGD dan mendapatkan informasi bahwa dokter Yoga complain. Perawat Vely segera turun untuk menggantikan perawat Nata di poli jantung.	



	Perawat Vely menjelaskan pada dokter yoga dan segera memasang infus serta dan menjalankan advice dokter yoga.	
--	---	--

Simpulan :

1. Jenis Insiden* :
 - ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
 - ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
 - ☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC
 - ☒ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
 - ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
2. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
 - ☒ Karyawan : Dokter
 - ☐ Pasien
 - ☐ Keluarga / Pendamping pasien
 - ☐ Pengunjung
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
3. Insiden terjadi pada* :
 - ☒ Pasien
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)

Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
4. Insiden menyangkut pasien :
 - ☒ Pasien rawat inap
 - ☐ Pasien rawat jalan
 - ☐ Pasien UGD
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
5. Tempat Insiden
IRNA 6A
6. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
 - ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anak dan Subspesialisasinya
 - ☐ Bedah dan Subspesialisasinya
 - ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
 - ☐ THT dan Subspesialisasinya
 - ☐ Mata dan Subspesialisasinya
 - ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
 - ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
 - ☐ Paru dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
 - ☒ Jantung dan Subspesialisnya
7. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
IRNA 6A
8. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
 - ☐ Kematian
 - ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
 - ☒ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
 - ☐ Cedera Ringan
 - ☐ Tidak ada cedera
9. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
 - Melakukan telusur kejadian
 - Rapat koordinasi



Ditemukan hasil bahwa

- 1. Sebelum IKP ini terjadi, Dokter Yoga telah menyampaikan masukan bahwa perawat diruangan masih kurang karena seringkali saat dokter Yoga Visite ada satu perawat dan perawat tersebut sedang melakuakn tindakan .
- 2. Kurangnya tenaga perawat untuk ruangan dengan mobilitas dan rencana tindakan yang cukup padat seperti dilantai 6A.
- 3. Kelalaian perawat yang tidak segera memasang infus yang terlepas hingga perawat shift pagi mengoperkan pada shift siang. Perawat shift siang akhirnya lupa hingga infus tidak terpasang sampai malam.
- 4. Perawat tidak mencatat prioritas yang harus dikerjakan
- 5. Persebaran perawat lama dan baru yang tidak merata menyulitkan kepala ruangan

10. Tindakan dilakukan oleh* :
- √ Tim, terdiri dari : Direktur, Kabid Keperawatan, SDM, Komite Mutu.
 - ☐ Perawat
 - ☐ Petugas lainnya
11. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
- ☐ Ya √ Tidak
- Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
- Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?**

.....

.....

.....

.....

Pembuat Laporan	: Anik	Penerima Laporan	: Alifia
Paraf	:	Paraf	: 
Tgl Lapor	: 21 Feb 2024	Tgl terima	: 21 Feb 2024

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

BIRU √ **HIJAU** **KUNING** **MERAH**

NB. * = pilih satu jawaban

III. **TIPE INSIDEN**

NO.	TIPE INSIDEN		SUBTIPE INSIDEN
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. <i>Consent</i> 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i>



			2. Diagnosis/ <i>assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart/</i> rekam medik/ <i>assessment/</i> konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands/</i> kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit 5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ <i>dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. <i>Supply/</i> pesan 7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi 6. Kontraindikasi



			- Salah penyimpanan <i>Ommited medicine or dose</i> - Obat kadaluarsa - Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	- Produk selular - Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) - Albumin/ plasma protein - Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	- Tes pre transfusi - Peresepan - Persiapan/ <i>dispensing</i> - Pengantaran - Pemberian - Penyimpanan - Monitoring - Presentasi/ pemaketan <i>Supply/</i> pesan
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah darah/ produk darah - Salah dosis/ frekuensi - Salah jumlah - Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi - Kontraindikasi - Salah penyimpanan - Obat atau dosis yang diabaikan - Darah kadaluarsa - Efek samping/ <i>adverse effect</i>
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	- Nutrisi umum - Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	- Peresepan/ permintaan - Pesiapan/ manufaktur/ memasak <i>Supply/</i> pesan - Penyajian <i>Dispensing/</i> alokasi - Pengantaran - Pemberian - Penyimpanan
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah diet - Salah jumlah - Salah frekuensi - Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	- Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> - Peresepan - Pemberian - Pengantaran <i>Supply/</i> order
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah gas - Salah <i>rate/ flow/</i> konsentrasi - Salah mode pengantaran - Kontraindikasi - Salah penyimpanan Gagal pemberian - Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	Presentasi/ pemaketan tidak baik



			2. Ketidaktersediaan 3. <i>Inapropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien 1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri. b. Agresi / <i>Assault</i> 1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa	
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh 1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan b. Keterlibatan saat jatuh 1. <i>Velbed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain	
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul 4. Kontak dengan benda/binatang 5. Kontak dengan orang 6. Hancur, remuk b. Serangantajam/ tusukan - Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan c. Kejadian mekanik lain 3. Benturan akibat ledakan bom 4. Kontak dengan mesin d. Peristiwa mekanik lain e. Mekanisme Panas - Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan f. Ancaman pada pernafasan - Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i> g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya 3. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 4. Bahan kimia korosif h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera 5. Paparan listrik/radiasi 6. Paparan suara/ getaran 7. Paparan tekanan udara 8. Paparan karena gravitasi rendah i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	6. Daftar struktur 7. Daftar bangunan 8. Daftar <i>furniture</i> 9. Inadekuat 10. Damaged/ faulty/ worn
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan	



		ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. <i>Protocols/</i> Kebijakan/ SOP Guideline c. Ketersediaan/ <i>Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ <i>pick up transport sorting data entry</i> proses verifikasi/ validasi hasil	

7. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)

1. Kurangnya tenaga perawat untuk ruangan dengan mobilitas dan rencana tindakan yang cukup padat seperti dilantai 6A.
2. Kelalaian perawat yang tidak segera memasang infus yang terlepas hingga perawat shift pagi mengoperkan pada shift siang. Perawat shift siang akhirnya lupa hingga infus tidak terpasang sampai malam.
3. Perawat tidak mencatat prioritas yang harus dikerjakan
4. Persebaran perawat lama dan baru yang tidak merata menyulitkan kepala ruangan

8. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)

1. Kurangnya tenaga perawat untuk ruangan dengan mobilitas dan rencana tindakan yang cukup padat seperti dilantai 6A.
2. Kelalaian perawat yang tidak segera memasang infus yang terlepas hingga perawat shift pagi mengoperkan pada shift siang. Perawat shift siang akhirnya lupa hingga infus tidak terpasang sampai malam.
3. Perawat tidak mencatat prioritas yang harus dikerjakan
4. Persebaran perawat lama dan baru yang tidak merata menyulitkan kepala ruangan

9. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	- Kurangnya tenaga perawat untuk ruangan dengan mobilitas dan rencana tindakan yang cukup padat seperti dilantai 6A. - Kelalaian perawat yang tidak segera memasang infus yang terlepas hingga perawat shift pagi mengoperkan pada shift siang. Perawat shift siang akhirnya lupa hingga infus tidak terpasang sampai malam. - Perawat tidak mencatat prioritas yang harus dikerjakan - Persebaran perawat lama dan baru yang tidak merata menyulitkan kepala ruangan	- Evaluasi jumlah ketenagaan dan persebaran perawat lama dan baru - Pengajuan perawat baru jika jumlah pasien terus meningkat - Kepala bidang keperawatan bersama kepala ruang harus memberikan motivasi kepada seluruh perawat agar meningkatkan rasa solidaritas sehingga tidak merasa keberatan untuk saling menolong dengan unit lain. - Memupuk rasa peduli kepada pasien dan antar sejawat.

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain

Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien



IKP 23 Februari 2024

- 3) Apoteker : Apt. Diryati Barin Putri, S.Farm
- 4) Tenaga Teknis Kefarmasian : Dia Ayu Wisnu Wardani, A.Md.Farm
- 5) Tenaga Teknis Kefarmasian : Desy Lailyssholikha, A.Md.Farm
- 6) Tenaga Teknis Kefarmasian : Laras Hadyaning Tias, A.Md.Farm

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama : ANDRA FIBRIYANTO
No. RM : 209943
Ruangan : IGD
Umur * : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan – 1 tahun
☐ > 1 tahun – 5 tahun ☐ > 5 tahun – 15 tahun
☐ > 15 tahun – 30 tahun ☒ > 30 tahun – 65 tahun
☐ > 65 tahun
Jenis kelamin : ☒ Laki-laki ☐ Perempuan
Penanggung biaya pasien : ☐ Pribadi ☐ Asuransi Swasta
☐ BPJS ☒ Lainnya (JKK)
Tanggal Masuk Ruangan :23 FEBRUARI 2024

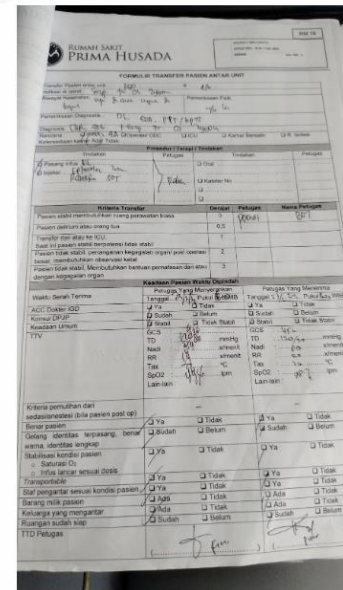
II. RINCIAN KEJADIAN

2. Tanggal dan Waktu Insiden

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
23/02/2024 13.48 WIB	Pasien datang dengan keluhan nyeri kepala, nyeri bahu dan luka di wajah post KLL Tunggul saat mau berangkat kerja	
23/02/2024 13.53 WIB	Pasien diperiksa oleh dr. Muchlas advis - Infus: RL - Injeksi: Ketorolac, Ranitidin - Cek Lab : DL, PPT KPTT , GDS - cek RO ct-scan brain trauma, CXR dan Shoulder	



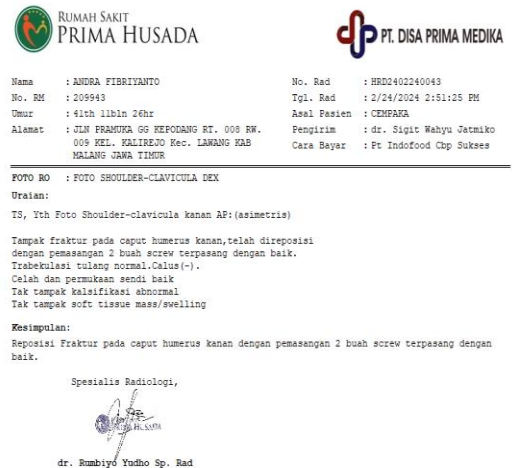
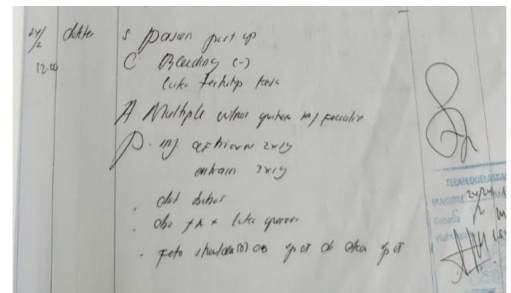
23/02/2024 14.00 WIB	Pasien dioperkan ke shift sore	
23/02/2024 15.00 WIB	- shift sore telah menerima operan pasien Tn andra dan sudah menerima foto thorax dan CT scan. Kemudian dr. Yuniar Ardy memeriksa ulang pasien, dan memutuskan tidak usah di lakukan pemeriksaan shoulder, karena dari hasil pmeriksaan aman dan sesuai AP dr. Yuniar Ardy, Perawat Beny mencoret advis dr. Muchlas RO Shoulder yang ada di Ass awal IGD dan pasien hanya dilakukan ct scan brain trauma dan thorax saja.	
23/02/2024 16.04 WIB	Pasien dikonsulkan dr. Sigit, Sp.BP Advis dr. Sigit, direncanakan op jam 06.00 besok paginya	
23/02/2024 17.14 WIB (balasan WA)	Pasien dikonsulkan ke dr. Dino, Sp.An Advis: Dopamed 3x500 mg po Amlodipin 2x10 mg po Metoclopramide 10 mg iv 1 jam sbllm op RL 20 tpm	



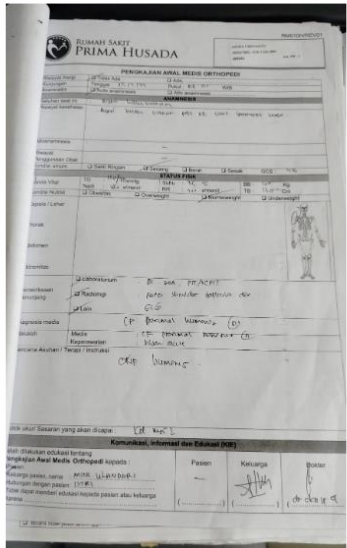
Pasien pindah ruangan ke
IRNA 4A

Pasien menjalani operasi dengan dokter Sigit, Sp.BP

Pasien mengeluh nyeri bahu kanan dan mendapatkan advice dari dokter Sigit untuk foto shoulder dextra konsul dokter Oka





	24-2-2024	Melaporkan foto pada dokter Oka dan didapatkan advice besok (25-2-2024) operasi pukul 08.00	
--	-----------	---	---

Simpulan : Operan shift tidak dijalankan dengan maksimal

- Jenis Insiden* :
 - ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
 - ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
 - ☒ Kejadian Tidak Cedera / KTC
 - ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
 - ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
- Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
 - ☒ Karyawan : Dokter
 - ☐ Pasien
 - ☐ Keluarga / Pendamping pasien
 - ☐ Pengunjung
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
- Insiden terjadi pada* :
 - ☒ Pasien
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)

Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
- Insiden menyangkut pasien :
 - ☐ Pasien rawat inap
 - ☐ Pasien rawat jalan
 - ☒ Pasien UGD
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
- Tempat Insiden
(di IGD RS Prima Husada Malang)
- Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
 - ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anak dan Subspesialisasinya
 - ☒ Bedah dan Subspesialisasinya
 - ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
 - ☐ THT dan Subspesialisasinya
 - ☐ Mata dan Subspesialisasinya
 - ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
 - ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
 - ☐ Paru dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya



☐ Lain-lain Urologi

7. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
IGD
8. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
☐ Kematian
☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
☐ Cedera Ringan
☒ Tidak ada cedera
9. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
Melakukan telusur dan diperoleh hasil :
Dokter shift sore tidak menjalankan seluruh operan dari dokter IGD shift pagi karena saat itu tidak pasien mengatakan tidak ada keluhan pada bahu. Hari berikutnya, pasien saat operasi dengan dokter bedah plastic, pasien mengtakan nyeri pada bahu kanan dan Ketika di foto ternyata ada fraktur sehingga pasien harus menjalani operasi kembali.
10. Tindakan dilakukan oleh* :
☒ Tim, terdiri dari : sekretaris komite PMKP, sub komite keselamatan pasien, kepala instalasi IGD, Kepala IGD
☐ Dokter
☐ Perawat
☐ Petugas lainnya
11. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
- Ya ☐ Tidak ☒
- Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?
.....
.....
.....
.....

Pembuat Laporan	: Perawat Beni	Penerima Laporan	: Alifia
Paraf	:	Paraf	: 
Tgl Lapor	: 29-2-2024	Tgl terima	: 29-2-2024

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :
☒ **BIRU** **HIJAU** **KUNING** **MERAH**
NB. * = pilih satu jawaban

III. **TIPE INSIDEN**

No.	Tipe Insiden		Subtipe Insiden
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. <i>Consent</i>



			10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i> 2. Diagnosis/ <i>assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart/</i> rekam medik/ <i>assessment/</i> konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands/</i> kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit 5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ <i>dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. <i>Supply/</i> pesan



			7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. <i>Omitted medicine or dose</i> 9. Obat kadaluarsa 10. Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Produk selular 2. Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) 3. Albumin/ plasma protein 4. Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Tes pre transfusi 2. Peresepan 3. Persiapan/ <i>dispensing</i> 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. Penyimpanan 7. Monitoring 8. Presentasi/ pemaketan 9. <i>Supply/</i> pesan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah darah/ produk darah 3. Salah dosis/ frekuensi 4. Salah jumlah 5. Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. Obat atau dosis yang diabaikan 9. Darah kadaluarsa 10. Efek samping/ <i>adverse effect</i>
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	1. Peresepan/ permintaan 2. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 3. <i>Supply/</i> pesan 4. Penyajian 5. <i>Dispensing/</i> alokasi 6. Pengantaran 7. Pemberian 8. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran 5. <i>Supply/</i> order
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas



			3. Salah <i>rate/ flow/</i> konsentrasi 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan 7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemakaian tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. <i>Inapropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Velbed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangantajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah



		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. <i>Protocols/ Kebijakan/ SOP Guideline</i> c. Ketersediaan/ <i>Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ <i>pick up transport sorting data entry</i> proses verifikasi/ validasi hasil	

10. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)

Dokter shift sore tidak menjalankan seluruh operan dari dokter IGD shift pagi karena saat itu tidak pasien mengatakan tidak ada keluhan pada bahu. Hari berikutnya, pasien saat operasi dengan dokter bedah plastic, pasien mengtakan nyeri pada bahu kanan dan Ketika di foto ternyata ada fraktur sehingga pasien harus menjalani operasi kembali.

11. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)

Dokter shift sore tidak menjalankan seluruh operan dari dokter IGD shift pagi karena saat itu tidak pasien mengatakan tidak ada keluhan pada bahu. Hari berikutnya, pasien saat operasi dengan dokter bedah plastic, pasien mengtakan nyeri pada bahu kanan dan Ketika di foto ternyata ada fraktur sehingga pasien harus menjalani operasi kembali.

12. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	Operan shift tidak dijalankan dengan maksimal	- Memperbaiki komunukasi dean operan antar shift - Meningkatkan kerjasam antar unit -

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain

Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselaman Pasien

IKP 23 September 2024

- Tenaga Teknis Kefarmasian

: Diryati Barin Putri, A.Md.Farm
- Tenaga Teknis Kefarmasian

: Farda Lolita Meisila, A.Md.Farm
- Tenaga Teknis Kefarmasian

: Evan Nur Luthfi Ramadhani, A.Md.Farm
- Tenaga Teknis Kefarmasian

: Laras Hadyaning Tias, S.Farm

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama

: An Aisyah az zahra

No. RM

: 216147

Ruangan

: IRJA

Umur *

☐ 0-1 bulan

☒ > 1 bulan – 1 tahun

☒ > 1 tahun – 5 tahun

☐ > 5 tahun – 15 tahun

☐ > 15 tahun – 30 tahun

☐ > 30 tahun – 65 tahun (63 tahun)

☐ > 65 tahun

Jenis kelamin :

☐ Laki-laki

☒ Perempuan

Penanggung biaya pasien

☐ Pribadi

☒ BPJS

☐ Asuransi Swasta

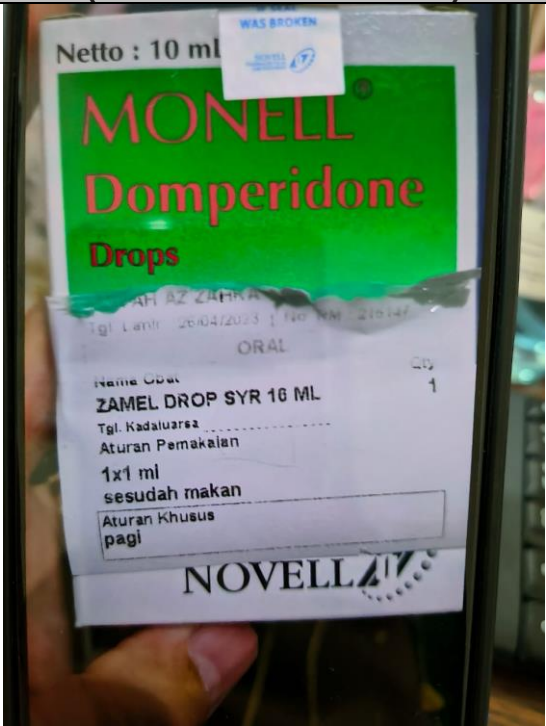
☐ Lainnya (sebutkan)

Tanggal Masuk Ruangan

:

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
23/09/2024	Pasien kontrol ke poli THT tanggal 23/09/2024 jam 07.35 WIB. Ibu pasien komplain ke dr Nimim, SpTHT-KL, karena infonya saat kontrol bulan lalu diberikan obat vitamin , tetapi dari farmasi diberikan obat yang lain. Tanggal 26/08/2024, dr Nimim, SpTHT-KL meresepkan Zamel drop 1x1. Ibu pasien menggunakan jasa primantara, saat obat sudah sampai di rumah, obat tidak langsung di cek, saat mau diminumkan, ibu pasien curiga karena di etiket dan botol kemasan tidak sama namanya. Akhirnya Ibu pasien searching google, karena takut dan tidak tahu fingsi obatnya, obat tersebut tidak berani diberikan ke anaknya sampai pasien kontrol kembali hari ini tanggal 23/09/2024.	



	Lapor ke yuan selaku Kains farmasi, obat Monell sudah diganti dengan obat Zamel. Ibu pasien tetap menggunakan jasa Pengantaran primantara, dan obat monell nya ditarik.	
--	---	--

Simpulan : Petugas tidak crosscek antara resep, etiket dengan obat yang diberikan.

2. Jenis Insiden* :

- ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
- ☒ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
- ☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC
- ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
- ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)

3. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*

- ☒ Karyawan : dr Nimim, SpTHT-KL
- ☐ Pasien
- ☐ Keluarga / Pendamping pasien
- ☐ Pengunjung
- ☐ Lain-lain(sebutkan)

4. Insiden terjadi pada* :

- ☒ Pasien
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
- Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.

5. Insiden menyangkut pasien :

- ☐ Pasien rawat inap
- ☒ Pasien rawat jalan
- ☐ Pasien UGD
- ☐ Lain-lain(sebutkan)

6. Tempat Insiden

Irja

7. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)

- ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
- ☐ Anak dan Subspesialisasinya
- ☐ Bedah dan Subspesialisasinya
- ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
- ☒ THT dan Subspesialisasinya
- ☐ Mata dan Subspesialisasinya
- ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
- ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
- ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
- ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
- ☐ Paru dan Subspesialisasinya
- ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
- ☐ Lain-lain Urologi

8. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden

Irja

9. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :

- ☐ Kematian
- ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
- ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
- ☐ Cedera Ringan
- ☒ Tidak ada cedera



10. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
Melakukan telusur dan didapatkan :
Petugas tidak crosscek antara resep, etiket dengan obat yang diberikan..
11. Tindakan dilakukan oleh* :
√ Tim, terdiri dari : komite PMKP, sub komite keselamatan pasien, petugas keuangan
☐ Dokter
☐ Perawat
☐ Petugas lainnya
12. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
- ☐ Ya √ Tidak
Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

.....
.....
.....
.....

Pembuat Laporan	: Puput Sekar N	Penerima Laporan	: Alifia
Paraf	:	Paraf	:
Tgl Lapor	: 23-9-2024	Tgl terima	: 25-4- 2024

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :
BIRU ☐ **HIJAU** ☐ **KUNING** √ **MERAH**
NB. * = pilih satu jawaban

III. **TIPE INSIDEN**

NO.	TIPE INSIDEN	SUBTIPE INSIDEN	
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. <i>Consent</i> 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i> 2. Diagnosis/ <i>assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat



			3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart</i>/ rekam medik/ <i>assessment</i>/ konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands</i>/ kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit 5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	1. Peresepan 2. <i>Persiapan/ dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. <i>Supply</i>/ pesan 7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. <i>Salah obat</i>
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. <i>Omitted medicine or dose</i> 9. Obat kadaluarsa 10. Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Produk selular 2. Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) 3. Albumin/ plasma protein 4. Imunoglobulin



		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Tes pre transfusi 2. Peresepan 3. Persiapan/ <i>dispensing</i> 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. Penyimpanan 7. Monitoring 8. Presentasi/ pemaketan 9. <i>Supply/ pesan</i>
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah darah/ produk darah 3. Salah dosis/ frekuensi 4. Salah jumlah 5. Salah label <i>dispensing/ Instruksi</i> 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. Obat atau dosis yang diabaikan 9. Darah kadaluarsa 10. Efek samping/ <i>adverse effect</i>
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	1. Peresepan/ permintaan 2. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 3. <i>Supply/ pesan</i> 4. Penyajian 5. <i>Dispensing/ alokasi</i> 6. Pengantaran 7. Pemberian 8. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran 5. <i>Supply/ order</i>
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas 3. Salah <i>rate/ flow/ konsentrasi</i> 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan 7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. <i>Inapropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya



			4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Vel/bed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangantajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim	



		b. <i>Protocols/</i> Kebijakan/ SOP Guideline c. <i>Ketersediaan/</i> <i>Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ <i>pick</i> <i>up transport sorting</i> <i>data entry</i> proses verifikasi/ validasi hasil	

13. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)
Petugas tidak crosscek antara resep, etiket dengan obat yang diberikan.
14. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)
Petugas tidak crosscek antara resep, etiket dengan obat yang diberikan.
15. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	Petugas tidak crosscek antara resep, etiket dengan obat yang diberikan.	

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain
Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselaman Pasien

IKP 02 Maret 2024

Tenaga Teknis Kefarmasian

: Evan Nur Luthfi Ramadhani, A.Md.Farm

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama : Tn. Tibyan

No. RM : 210293

Ruangan : Poli Syaraf – IGD

Umur * :

☐ 0-1 bulan

☐ > 1 bulan – 1 tahun

☐ > 1 tahun – 5 tahun

☐ > 5 tahun – 15 tahun

☐ > 15 tahun – 30 tahun

☐ > 30 tahun – 65 tahun

☒ > 65 tahun

Jenis kelamin :

☒ Laki-laki

☐ Perempuan

Penanggung biaya pasien :

☐ Pribadi

☐ BPJS

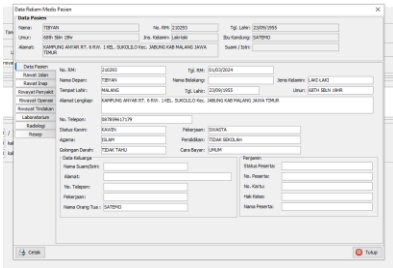
☐ Asuransi Swasta

☐ Lainnya (sebutkan)

Tanggal Masuk Ruangan :

II. RINCIAN KEJADIAN

3. Tanggal dan Waktu Insiden

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
1/3/2024	Pasien datang untuk periksa ke poli syaraf dokter Syahrir atas dasar rujukan dari puskesmas. Jam 14.08 pasien selesai di daftar dan menunggu panggilan di depan poli syaraf. Pada saat pasien di panggil masuk ke ruang poli syaraf, pasien sudah terlihat lemas, awal tensi teraba lemah 80/40 mmhg. Kemudian pasien diperiksa dokter syahrir. Pada saat pemeriksaan, dr syahrir mencoba mengangkat tangan pasien tetapi tidak ada respon, GCS 1-1-1. Perawat melakukan pemeriksaan tensi ulang tetapi nadi tidak teraba. Akhirnya dokter syahrir menyarankan langsung dibawa ke IGD, perawat mendampingi keluarga untuk membawa pasien ke IGD dengan kursi roda. Berdasarkan keterangan dokter Syahrir, jika dilihat dari kondisi pasien , puskesmas seharusnya tidak merujuk ke poli. GCS saat diperikas 1-1-2 dan keluarga mengatakan pasien masih bisa bergerak.	Pasien baru pertama kali berobat ke rumah sakit prima husada malang ,  



1/3/2024	Pasien tiba di UGD dengan kondisi tidak sadar, nadi tidak teraba dan telah midriasis. Petugas IGD melkaukan RJP tetapi oasien tidak tertolong. Pasien dinyatakan meninggal pukul 15.04	
	Keluarga mengatakan bahwa sebelumnya pasien masih bisa diajak berbicara. Sebelumnya pasien berobat ke puskesmas dan diarahkan untuk berobat ke poli spesialis	

Simpulan : petugas tidak melakukan identifikasi perburukan kondisi pada pasien.

- Jenis Insiden* :
 - ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
 - ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
 - ☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC
 - ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
 - ☒ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
- Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
 - ☒ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
 - ☐ Pasien
 - ☐ Keluarga / Pendamping pasien
 - ☐ Pengunjung
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
- Insiden terjadi pada* :
 - ☒ Pasien
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)

Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
- Insiden menyangkut pasien :
 - ☐ Pasien rawat inap
 - ☒ Pasien rawat jalan
 - ☐ Pasien UGD
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
- Tempat Insiden
Irja poli syaraf dan IGD
- Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
 - ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anak dan Subspesialisasinya
 - ☐ Bedah dan Subspesialisasinya
 - ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
 - ☐ THT dan Subspesialisasinya
 - ☐ Mata dan Subspesialisasinya
 - ☒ Saraf dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
 - ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
 - ☐ Paru dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
 - ☐ Lain-lain Urologi



7. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden Irja
8. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
√ Kematian
☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
☐ Cedera Ringan
☐ Tidak ada cedera
9. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
Melakukan telusur dan didapatkan data :
- Pasien mengalami penurunan kesadaran ketika sedang menunggu panggilan DPJP
- Petugas tidak dapat mengidentifikasi tanda penurunan kondisi pada pasien sehingga saat itu pasien dibawa ke IGD dengan kursi
10. Tindakan dilakukan oleh* :
√ Tim, terdiri dari : komite PMKP, sub komite keselamatan pasien, perawat Irja dan IGD
☐ Dokter
☐ Perawat
☐ Petugas lainnya
11. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
- ☐ Ya √ Tidak
Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?
.....
.....
.....
.....

Pembuat Laporan	:	Penerima Laporan	: Alifia
Paraf	:	Paraf	:
Tgl Lapor	:	Tgl terima	: 5 Maret 2024

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :
BIRU ☐ **HIJAU** ☐ **KUNING** √ **MERAH**
NB. * = pilih satu jawaban

III. **TIPE INSIDEN**

NO.	TIPE INSIDEN		SUBTIPE INSIDEN
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. <i>Consent</i> 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia



			4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i> 2. Diagnosis/ <i>assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ <i>investigasi</i> 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart/</i> rekam medik/ <i>assessment/</i> konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands/</i> kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit 5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ <i>dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. <i>Supply/</i> pesan 7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi



			- Salah rute pemberian - Salah jumlah/ kuantitas - Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi - Kontraindikasi - Salah penyimpanan <i>Omitted medicine or dose</i> - Obat kadaluarsa - Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	- Produk selular - Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) - Albumin/ plasma protein - Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	- Tes pre transfusi - Peresepan - Persiapan/ <i>dispensing</i> - Pengantaran - Pemberian - Penyimpanan - Monitoring - Presentasi/ pemaketan <i>Supply/</i> pesan
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah darah/ produk darah - Salah dosis/ frekuensi - Salah jumlah - Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi - Kontraindikasi - Salah penyimpanan - Obat atau dosis yang diabaikan - Darah kadaluarsa - Efek samping/ <i>adverse effect</i>
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	- Nutrisi umum - Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	- Peresepan/ permintaan - Pesiapan/ manufaktur/ memasak <i>Supply/</i> pesan - Penyajian <i>Dispensing/</i> alokasi - Pengantaran - Pemberian - Penyimpanan
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah diet - Salah jumlah - Salah frekuensi - Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	- Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> - Peresepan - Pemberian - Pengantaran <i>Supply/</i> order
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah gas - Salah <i>rate/ flow/</i> konsentrasi - Salah mode pengantaran - Kontraindikasi - Salah penyimpanan - Gagal pemberian - Kontaminasi



9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. <i>Inapropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Velbed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangantajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat



			5. Damaged/ faulty/ worn
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. <i>Protocols/</i> Kebijakan/ SOP Guideline c. Ketersediaan/ <i>Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ <i>pick up transport sorting data entry</i> proses verifikasi/validasi hasil	

1. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)
Petugas tidak melakukan identifikasi perburukan kondisi pada pasien.
2. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)
 - Petugas tidak dapat memahami cara mengidentifikasi tanda penurunan kondisi pada pasien sehingga saat itu pasien dibawa ke IGD dengan kursi
3. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	Petugas tidak dapat memahami cara mengidentifikasi tanda penurunan kondisi pada pasien sehingga saat itu pasien dibawa ke IGD dengan kursi	Segera dilakukan pelatihan code blue untuk seluruh staff
2	Code Blue tidak berjalan	Memperbarui SK tim code blue dan mengaktifkan Kembali tim code blue untuk bergerak

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain
Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

IKP 25 September 2024

Tenaga Teknis Kefarmasian

: Laras Hadyaninig Tias, A.Md.Farm

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama : Raysha Callie Agneta Myesha

No. RM : 197693

Ruangan : DEPO FARMASI

Umur * :

☐ 0-1 bulan

☐ > 1 bulan – 1 tahun

☒ > 1 tahun – 5 tahun

☐ > 5 tahun – 15 tahun

☐ > 15 tahun – 30 tahun

☐ > 30 tahun – 65 tahun

☐ > 65 tahun

Jenis kelamin :

☐ Laki-laki

☒ Perempuan

Penanggung biaya pasien :

☐ Pribadi

☒ BPJS

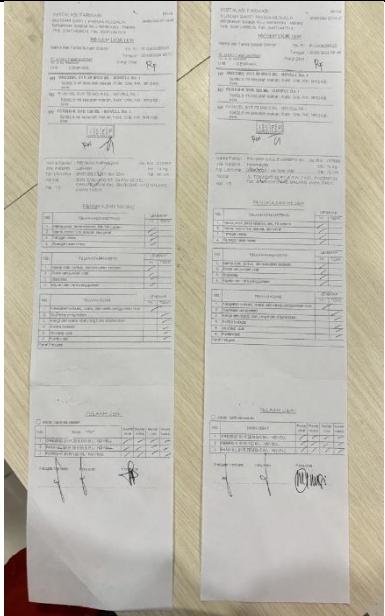
☐ Asuransi Swasta

☐ Lainnya (sebutkan)

Tanggal Masuk Ruangan : 25 September 2024

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
25/09/24 pukul 07.18	dr. Dicky, Sp.A meresepkan obat RF Orezinc syr S2dd2,5 ml, Ferro-K syr S2dd2,5 ml, Ranivel syr S2dd2,5 ml. Petugas input (Laras) melakukan pengkajian resep yaitu telaah administrasi, farmasetik dan klinis. Petugas menyimpan resep dan etiket sesuai inputan DPJP, petugas cetak resep dan obat. Kemudian disiapkan dan ditempelkan etiket pada obat oleh petugas (Ferra A.). Pukul 08.46 Petugas KIE (Laras) memanggil pasien dan KIE obat. Keluarga pasien kembali lagi ke depo farmasi karena etiket obat yang tertempel an pasien Reynan (212553). Setelah di telusur resepnya obat sudah sesuai resep namun etiketnya salah. Laras mengganti etiket obat sesuai nama pasien Raysha (197693) dan mengganti etiket obat Reynan (212553) karena obatnya belum diambil.	



	Pukul 09.02 keluarga Reynan (212553) mengambil obat dengan etiket yang sudah sesuai.	
--	--	--

Simpulan : kesalahan penempelan etiket obat

2. Jenis Insiden* :
 - ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
 - ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
 - ☒ Kejadian Tidak Cedera / KTC
 - ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
 - ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
3. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
 - ☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
 - ☒ Pasien
 - ☐ Keluarga / Pendamping pasien
 - ☐ Pengunjung
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
4. Insiden terjadi pada* :
 - ☒ Pasien
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)

Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
5. Insiden menyangkut pasien :
 - ☒ Pasien rawat inap
 - ☐ Pasien rawat jalan
 - ☐ Pasien UGD
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
6. Tempat Insiden
Instalasi Farmasi
(Tempat pasien berada)
7. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
 - ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
 - ☒ Anak dan Subspesialisasinya
 - ☐ Bedah dan Subspesialisasinya
 - ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
 - ☐ THT dan Subspesialisasinya
 - ☐ Mata dan Subspesialisasinya
 - ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
 - ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
 - ☐ Paru dan Subspesialisasinya
 - ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
 - ☐ Lain-lain Urologi
8. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden: Instalasi Farmasi
9. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
 - ☐ Kematian



- ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
- ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
- ☐ Cedera Ringan
- ✓ Tidak ada cedera

10. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
Farmasi mengganti etiket obat sesuai nama pasien Raysha (197693) dan mengganti etiket obat Reynan (212553) karena obatnya belum diambil.

11. Tindakan dilakukan oleh* :
- ✓ Tim, terdiri dari : Instalasi Farmasi
 - ☐ Dokter
 - ☐ Perawat
 - ☐ Petugas lainnya

12. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
- ☐ Ya ✓ Tidak
- Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
- Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?**

.....

.....

.....

.....

Pembuat Laporan	: Yuanita	Penerima Laporan	:
Paraf	:	Paraf	:
Tgl Lapor	: 26/09/2024	Tgl terima	:

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

☐ **BIRU** ✓ **HIJAU** ☐ **KUNING** **MERAH**

NB. * = pilih satu jawaban

III. **TIPE INSIDEN**

No.	Tipe Insiden		Subtipe Insiden
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. <i>Consent</i> 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan



2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i> 2. Diagnosis/ <i>assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart/</i> rekam medik/ <i>assessment/</i> konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands/</i> kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit 5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ <i>dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. <i>Supply/</i> pesan 7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi



			3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. <i>Omitted medicine or dose</i> 9. Obat kadaluarsa 10. Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Produk selular 2. Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) 3. Albumin/ plasma protein 4. Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Tes pre transfusi 2. Peresepan 3. Persiapan/ <i>dispensing</i> 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. Penyimpanan 7. Monitoring 8. Presentasi/ pemaketan 9. <i>Supply/</i> pesan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah darah/ produk darah 3. Salah dosis/ frekuensi 4. Salah jumlah 5. Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. Obat atau dosis yang diabaikan 9. Darah kadaluarsa 10. Efek samping/ <i>adverse effect</i>
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	1. Peresepan/ permintaan 2. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 3. <i>Supply/</i> pesan 4. Penyajian 5. <i>Dispensing/</i> alokasi 6. Pengantaran 7. Pemberian 8. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran 5. <i>Supply/</i> order
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas 3. Salah <i>rate/ flow/</i> konsentrasi 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan



			7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. <i>Inapropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminatif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Velbed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangan tajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif



		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. <i>Protocols/ Kebijakan/ SOP Guideline</i> c. <i>Ketersediaan/ Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambil an/ <i>pick up transport sorting data entry</i> proses verifikasi/ validasi hasil	

1. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)
Tidak melakukan double check saat pemasangan etiket obat, serta dalam proses penyerahan ke pasien.
2. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)
Ketidaktelitian petugas farmasi dalam penempelan etiket dan penyerahan obat karena etiket obat pasien tertukar.

3. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	Ketidaktelitian petugas dalam penempelan etiket, dan penyerahan obat.	1. Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check). 2. Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga



		dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
--	--	---

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain

Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

IKP 15 April 2024

Radiographer : Muhammad Iqbal Maulana, A.Md.Rad

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN (INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama : Ny. Jumlahah
No. RM : 212698
Ruangan : IRJA
Umur * : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan – 1 tahun
☐ > 1 tahun – 5 tahun ☐ > 5 tahun – 15 tahun
☐ > 15 tahun – 30 tahun ☒ > 30 tahun – 65 tahun (63 tahun)
☐ > 65 tahun
Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☒ Perempuan
Penanggung biaya pasien : ☒ Pribadi ☐ Asuransi Swasta
☐ BPJS ☐ Lainnya (sebutkan)
Tanggal Masuk Ruangan :

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
15/4/2024 17.58	Pasien atas nama Ny. Jumila datang di damping suami atas nama Tn. Tarjo. Pasien datang ke poli penyakit dalam dokter Ardi dengan keluhan nyeri dada sejak 1 bulan yang lalu. Pasien telah dilakukan pemeriksaan dokter , pemeriksaan thorax dan mendapatkan obat. Pasien pulang pada hari itu juga. Saat di radiologi, petugas Iqbal memanggil pasien atas nama Tn. Tarjo. Tn. Tarjo mengatakan bahwa yang sakit adalah istrinya. Petugas Iqbal menjelaskan kepada anak pasien bahwa yang ditulis di permintaan adalah atas nama Tn. Tarjo. Anak pasien mengatakan bahwa tidak apa-apa tadi memang di daftarkan pakai KTP bapak. Petugas Iqbal tidak melakukan konfirmasi pada pendaftaran dan melakuakn pemeriksaan thorax pada Ny. Jumilah tanpa melakukan konfirmasi atau laporan pada pendaftaran. Dan hasil pemeriksaan Thorax di input pada billing Tn. Tarjo.	
22/4/2024	Pasien datang control dengan keluhan sebelumnya yang sudah membaik dengan menggunakan register tetap Tn. Tarjo dan telah melakuakn pembayaran.	



	Pasien periksa ke poli penyakit dalam dan diarahkan ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah. Petugas laborat menerima form permintaan atas nama Tn. Tarjo. Ketika akan di ambil darah,Tn. Tarjo mengatakan “lho yang sakit istri saya” Kemudian petugas laborat melaporkan kepada petugas pendaftaran. Akhirnya petugas pendaftaran melakukan pendafatran ulang dengan pasien yang benar yaitu Ny. Jumilah.	
22/4/2024	Petugas kasir menerima laporan untuk memindahakn pembayaran tagihan Tn, Tarjo ke tagian Ny. Jumilah di tanggal 22-4-2025 dan diminta untuk mengalihkan pembayaran tanggal 15.00 dari Tn. Tarjo ke Ny. Jumilah namun kasir tidak bisa melakukan karena tanggal 15 tidak ada kunjungan atas nama Ny. Jumilah,	

Simpulan : petugas tidak melakukan konfirmasi saat pasien mendaftar hingga dilakukan pemeriksaan.

2. Jenis Insiden* :
- ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
 - ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
 - ☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC
 - ☒ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
 - ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
3. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
- ☒ Karyawan : petugas kasir dan laborat
 - ☐ Pasien
 - ☐ Keluarga / Pendamping pasien
 - ☐ Pengunjung
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
4. Insiden terjadi pada* :
- ☒ Pasien
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
- Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
5. Insiden menyangkut pasien :
- ☐ Pasien rawat inap
 - ☒ Pasien rawat jalan
 - ☐ Pasien UGD
 - ☐ Lain-lain(sebutkan)
6. Tempat Insiden
- Irja
7. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
- ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
 - ☐ Anak dan Subspesialisasinya
 - ☐ Bedah dan Subspesialisasinya
 - ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
 - ☐ THT dan Subspesialisasinya
 - ☐ Mata dan Subspesialisasinya



- ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
- ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
- ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
- ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
- ☐ Paru dan Subspesialisasinya
- ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
- ☐ Lain-lain Urologi

8. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
Irja

9. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :

- ☐ Kematian
- ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
- ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
- ☐ Cedera Ringan
- ☐ Tidak ada cedera

10. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :

Melakukan telusur dan didapatkan :

petugas tidak melakukan konfirmasi saat pasien mendaftar hingga dilakukan pemeriksaan.

11. Tindakan dilakukan oleh* :

✓ Tim, terdiri dari : komite PMKP, sub komite keselamatan pasien, petugas keuangan

- ☐ Dokter
- ☐ Perawat
- ☐ Petugas lainnya

12. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*

☐ Ya ✓ Tidak

Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.

Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

.....
.....
.....
.....

Pembuat Laporan	:	Penerima Laporan	: Alifia
Paraf	:	Paraf	:
Tgl Lapor	:	Tgl terima	: 25-4- 2024

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

BIRU ☐ **HIJAU**

☐ **KUNING**

✓ **MERAH**

NB. * = pilih satu jawaban

III. TIPE INSIDEN

NO.	TIPE INSIDEN		SUBTIPE INSIDEN
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. <i>Consent</i> 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan



		b. Masalah	6. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 7. Tidak lengkap/ inadekuat 8. Tidak tersedia 9. Salah pasien 10. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i> 2. Diagnosis/ <i>assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart</i> / rekam medik/ <i>assessment</i> / konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands</i> / kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit 5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Ciaran infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ <i>dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. <i>Supply</i> / pesan 7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi 6. Kontraindikasi



			- Salah penyimpanan <i>Ommited medicine or dose</i> - Obat kadaluarsa - Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	- Produk selular - Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) - Albumin/ plasma protein - Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	- Tes pre transfusi - Peresepan - Persiapan/ <i>dispensing</i> - Pengantaran - Pemberian - Penyimpanan - Monitoring - Presentasi/ pemaketan <i>Supply/ pesan</i>
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah darah/ produk darah - Salah dosis/ frekuensi - Salah jumlah - Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi - Kontraindikasi - Salah penyimpanan - Obat atau dosis yang diabaikan - Darah kadaluarsa - Efek samping/ <i>adverse effect</i>
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	- Nutrisi umum - Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	- Peresepan/ permintaan - Pesiapan/ manufaktur/ memasak <i>Supply/ pesan</i> - Penyajian <i>Dispensing/</i> alokasi - Pengantaran - Pemberian - Penyimpanan
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah diet - Salah jumlah - Salah frekuensi - Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	- Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> - Peresepan - Pemberian - Pengantaran <i>Supply/ order</i>
		c. Masalah	- Salah pasien - Salah gas - Salah <i>rate/ flow/</i> konsentrasi - Salah mode pengantaran - Kontraindikasi - Salah penyimpanan - Gagal pemberian - Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	- Presentasi/ pemaketan tidak baik - Ketidakterediaan <i>Inaproiate for task</i> - Tidak bersih/ tidak steril - Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	- Tidak kooperatif - Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar



			3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Velbed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangan tajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat 5. <i>Damaged/ faulty/ worn</i>
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. <i>Protocols/ Kebijakan/ SOP Guideline</i> c. Ketersediaan/ <i>Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ <i>pick up transport sorting data</i>	

		entry proses verifikasi/ validasi hasil	
--	--	--	--

1. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)
Petugas tidak melakukan konfirmasi saat pasien mendaftar hingga dilakukan pemeriksaan.
2. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)
Petugas tidak melakukan konfirmasi saat pasien mendaftar hingga dilakukan pemeriksaan.
3. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	Petugas tidak melakukan konfirmasi saat pasien mendaftar hingga dilakukan pemeriksaan.	

NB.*

: Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain

Saran

: Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselaman Pasien

Malang, 14 Desember 2024

Kepala Bidang Umum
dan Keuangan



drg. Endy Wira
Pradana, M.MRS

PLT Kepala Bidang
Pelayanan Medis



dr. Wiryantari
Akhdani Pratiwi

PLT Kepala Bidang
Penunjang Medis



Putri Indah
Purnamasari,
A.Md.Kep

Kepala Bidang
Keperawatan



Ns. Very Susanto,
S.Kep

PLT Direktur RS Prima Husada Malang

SDM RS Prima Husada Malang

dr. Nur Mazidah

Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi